MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO DE COSTA RICA

Boletín Epidemiológico N° 41 de 2026

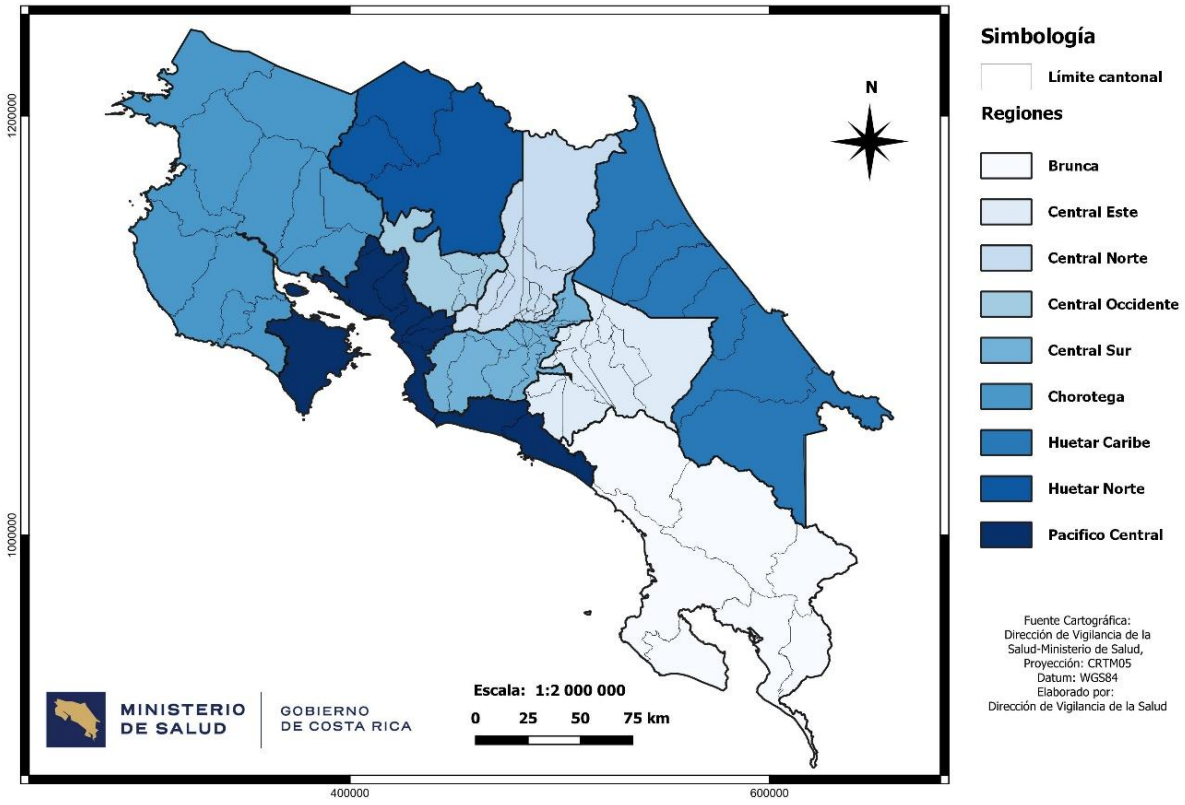
Dirección de Vigilancia de la Salud
Ministerio de Salud

6 de noviembre de 2026

Tabla de contenido

Arbovirosis 3
Situación de la malaria en Costa Rica 7
Acciones de control vectorial realizadas en el país a la semana epidemiológica 41 17
Influenza y otras virosis respiratorias, IRAG, IRAS, ETI, neumonía y Covid-19 18
Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) al 2 de noviembre 2026. 34
Infecciones de transmisión sexual 43
Miasis por gusano barrenador en humanos 50
La Poliomielitis 55

Costa Rica. Regionalización Ministerio de Salud, 2024



Arbovirosis

Dengue

A la semana epidemiológica 42 del año 2026 se notifican **6594 casos acumulados** de dengue de estos, **105 casos** como dengue con signos de alarma.
La Gerencia Médica de la CCSS a través del Área de Estadística en Salud según los datos recopilados mediante EDUS informa que al 2 de noviembre se reportan 3 personas hospitalizadas con diagnóstico de dengue: 1 en el Hospital Max Terán, 1 en el Hospital San Monseñor Sanabria y 1 en el Hospital de Alajuela.
La región Central Norte presenta el mayor número de casos notificados 1969 y la tasa más alta la presenta la región Pacífico Central con 450,8/100.000 habitantes.

Tabla 1.
Costa Rica: Casos y tasas de dengue por región a la semana epidemiológica 42 2026 (Tasa por 100.000 hab.)

Región	Casos	Tasa
Central Norte	1969	188,0
Pacifico Central	1451	450,8
Chorotega	879	185,3
Central Sur	864	57,1
Huetar Caribe	553	120,8
Central Occidente	332	147,9
Huetar Norte	263	96,9
Brunca	206	58,3
Central Este	77	13,9
Total	6594	126,4

Fuente: Base VE01, Dirección de Vigilancia de la Salud.

Tabla 2.
Costa Rica: casos de dengue notificados por provincia y sexo, 2026

Provincia	Total casos	Tasa	Femenino	Tasa	Masculino	Tasa
Alajuela	2791	257,8	1483	274,5	1308	241,1
Puntarenas	981	192,8	463	183,9	518	201,5
San José	880	52,8	441	52,2	439	53,5
Guanacaste	841	201,6	434	209,8	407	193,6
Limón	553	120,8	243	108,6	310	132,5
Heredia	471	85,5	249	90,0	222	81,0
Cartago	77	14,4	38	14,2	39	14,7
Total	**6594**	**126,4**	**3351**	**128,2**	**3243**	**124,5**

Fuente: Base VE 01, Dirección de Vigilancia de la Salud.

Los cantones con mayor número de casos acumulados a la semana epidemiológica 42 son: Grecia 727 casos, Alajuela 658 casos, Orotina 591 casos, San José 418 casos y Puntarenas 416 casos.

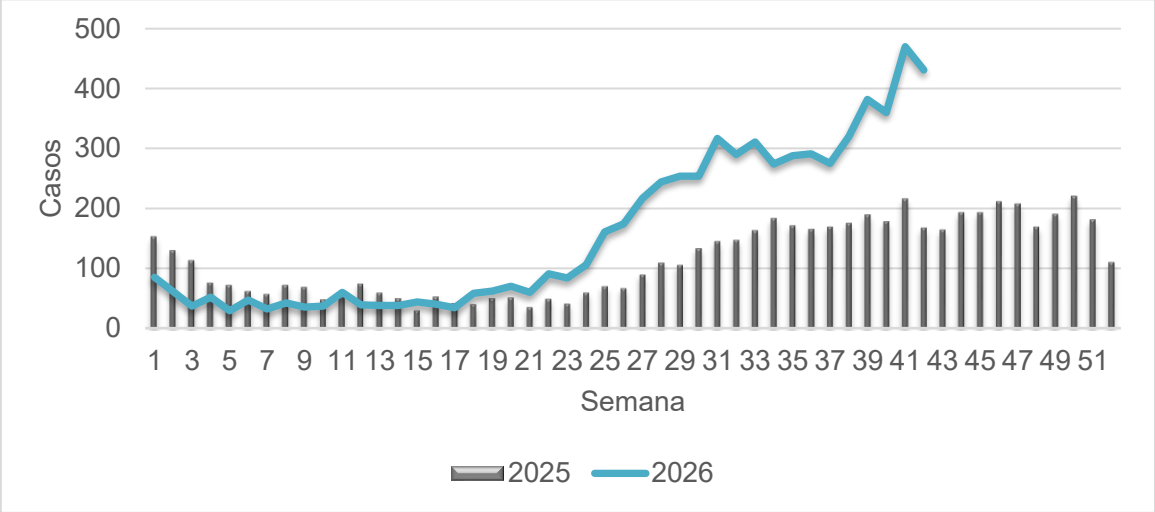
Tabla 3.
Costa Rica: cantones prioritarios de dengue por casos notificados a la semana epidemiológica 42, 2026.

Cantón	Casos	Tasa
203: Grecia	727	893,2
201: Alajuela	658	199,3
209: Orotina	591	2323,8
101: San José	418	118,1
601: Puntarenas	416	285,8
401: Heredia	240	162,8
510: La Cruz	208	733,4
702: Pococí	191	121,5
501: Liberia	175	212,0

109: Santa Ana	168	268,6

Fuente: Base VE01, Dirección de Vigilancia de la Salud

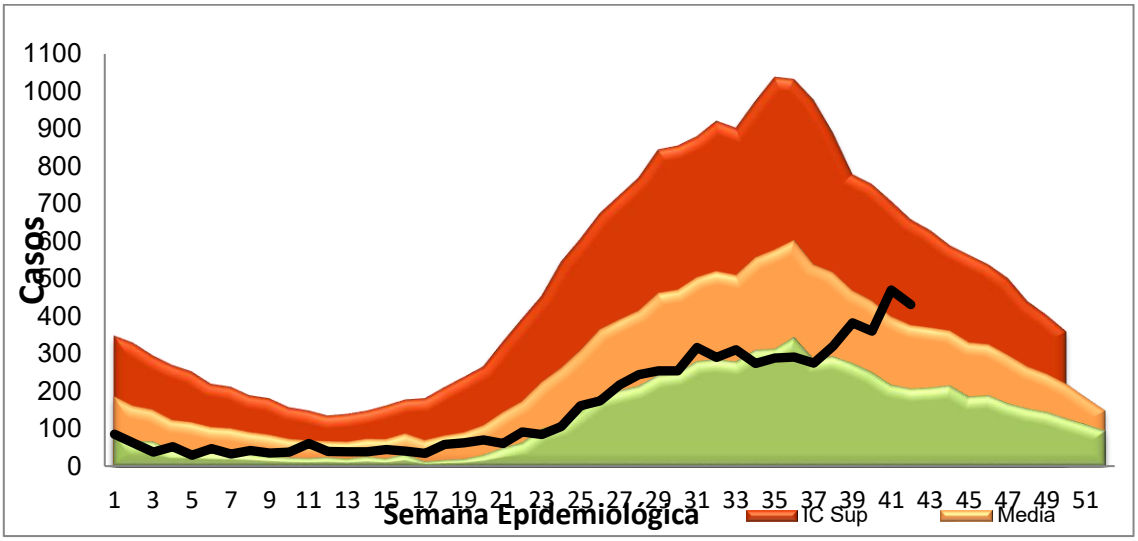
Gráfico 1.
Costa Rica: casos de dengue a la semana epidemiológica 42, 2025-2026.



Fuente: Base VE01, Dirección de Vigilancia de la Salud

Para la semana epidemiológica 42 del año 2025 se reportaron 4181 casos. En comparación con ese período, para el año 2026 se observa un incremento del 36,6% en el número de casos notificados.

Gráfico 2.
Costa Rica: canal endémico de dengue a la semana epidemiológica 42, 2026.



Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud

Chikungunya

A la semana epidemiológica 42 se notifica un total de **1049 casos** de chikungunya, **916 casos confirmados** por prueba de PCR y **133 casos probables** en estudio.

Tabla 4.
Costa Rica: Casos de chikungunya por región notificados y confirmados a la semana epidemiológica 42, 2026

Región	Total	Confirmados	Probables
Chorotega	602	547	55
Central Norte	186	167	19
Central Sur	127	94	33
Huetar Norte	46	37	9
Pacifico Central	45	38	7
Central Occidente	22	20	2
Central Este	11	7	4
Huetar Caribe	7	4	3
Brunca	3	2	1
Total	**1049**	**916**	**133**

Fuente: Base VE01, Dirección de Vigilancia de la Salud

Los cantones con mayor reporte de casos son:

- La Cruz 389 casos
- Alajuela 136 casos
- Carrillo 90 casos
- San José 71 casos
- Santa Cruz 64 casos
- Los Chiles 27 casos

Situación de la malaria en Costa Rica

Semana epidemiológica 42, 2026

En 2026 se registran 40 casos de malaria por transmisión local

Los casos de transmisión local son los que se adquirieron dentro del país: 19 autóctonos y 21 introducidos. El 75 % corresponde al **foco Crucitas** (distrito de Cutris, cantón de San Carlos, Región Huetar Norte), una zona de minería artesanal en la frontera con Nicaragua.

40	51
CASOS DE TRANSMISIÓN LOCAL 19 autóctonos y 21 introducidos	**CASOS IMPORTADOS** 48 con lugar probable de infección en Nicaragua

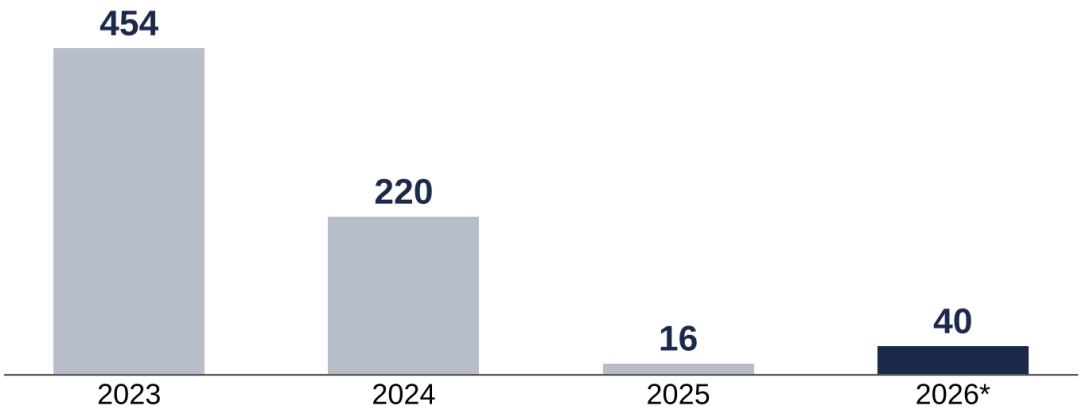
Casos nuevos en las semanas epidemiológicas 41 y 42

- **Los Chiles (localidad de El Parque):** 3 casos introducidos por *P. vivax* (SE 41 y 42), diagnosticados entre el 19 y el 23 de octubre. El tercero se detectó por búsqueda reactiva alrededor de los primeros casos. El foco Los Chiles vuelve a registrar transmisión local.
- **Matina (Región Huetar Caribe):** 1 caso importado por *P. vivax*, con lugar probable de infección en Puerto Cabezas, Nicaragua.
- **Garabito (Región Pacífico Central):** 1 caso clasificado como recaída por *P. vivax*.
- **Foco Crucitas:** 1 caso en estudio, detectado por búsqueda reactiva.

Comparación histórica de la transmisión local

Los casos de transmisión local acumulados a la SE 42 se redujeron de **454 en 2023 a 40 en 2026** (−91,2 %) y de 220 en 2024 (−81,8 %). Respecto a 2025 (16 casos) hay un aumento de 150 %, atribuible principalmente al brote del foco Crucitas.

Gráfico 1.
Casos de malaria por transmisión local acumulados a la SE 42, Costa Rica, 2023–2026

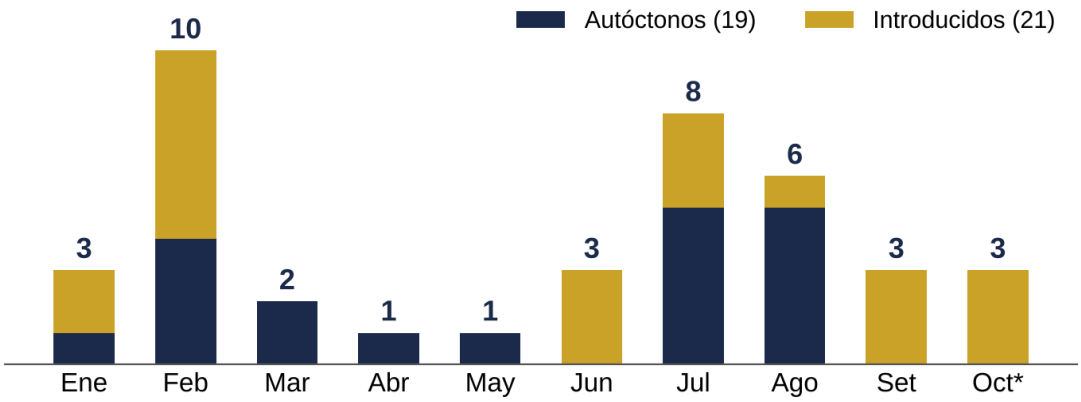


*2026: datos al corte de la SE 42 (24 de octubre).
Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud.

Distribución temporal

La transmisión local se concentró en dos periodos: **febrero** (10 casos, 6 introducidos) y **julio–agosto** (14 casos, 10 autóctonos). En **setiembre y octubre** se registraron 6 casos introducidos: 3 en la Región Chorotega y 3 en Los Chiles.

Gráfico 2.
Casos de malaria por transmisión local según mes de diagnóstico y clasificación epidemiológica, Costa Rica, enero–octubre 2026

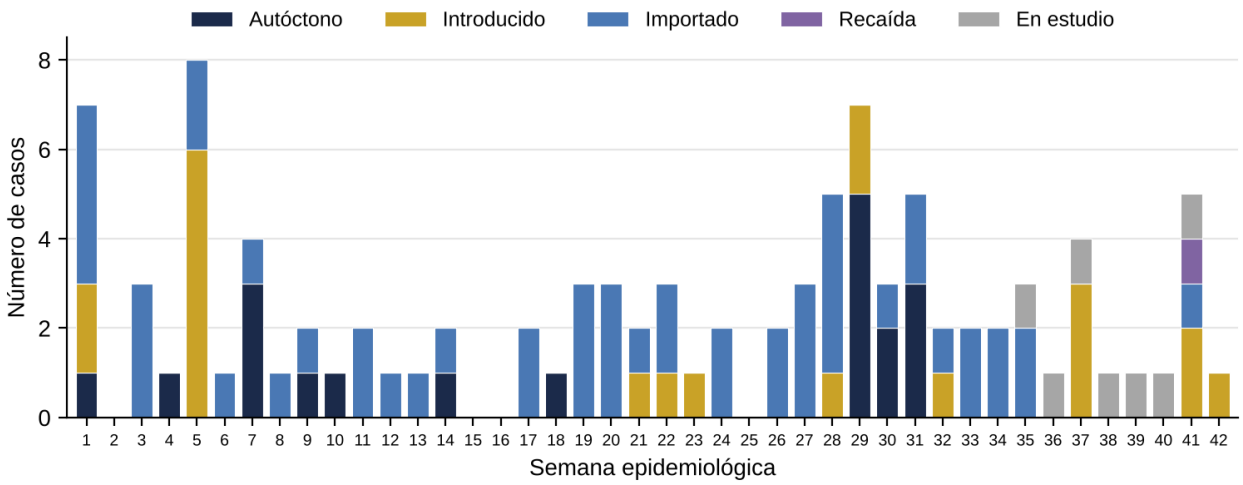


*Octubre: datos al 24 de octubre. Las cifras recientes pueden variar al cerrarse las investigaciones en curso.
Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud

Al incluir todos los casos confirmados, los casos importados se presentan de forma continua durante el año, mientras que la transmisión local se agrupa en las semanas

1–7 y 28–32 y reaparece en las SE 37 y 41–42. Los 7 casos en estudio corresponden a las SE 35 a 41, en el foco Crucitas.

Gráfico 3.
Casos confirmados de malaria según semana epidemiológica y clasificación epidemiológica, Costa Rica, 2026 (corte SE 42)



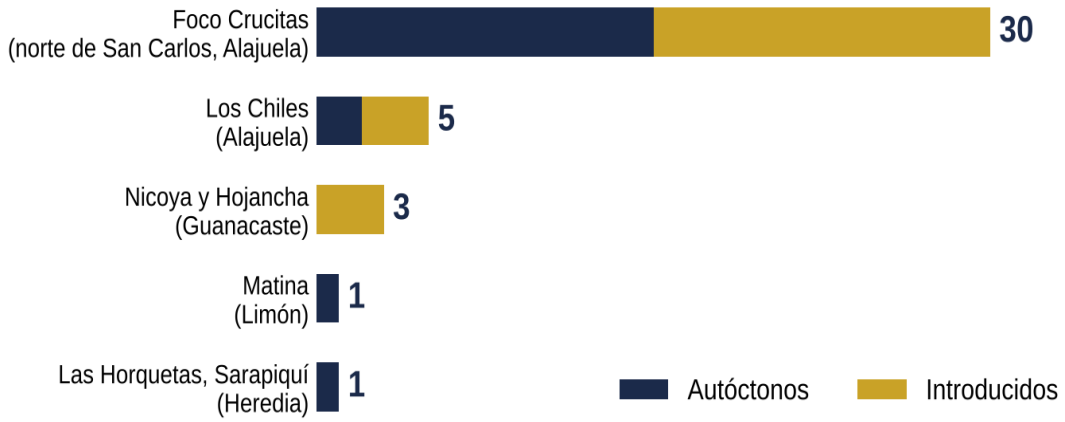
Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud.

Distribución geográfica por foco

El foco Crucitas concentra 30 de los 40 casos de transmisión local (75 %): 15 autóctonos y 15 introducidos. La mayoría reside en el distrito de Cutris, y la localidad de El Roble aporta 15 casos. Es una zona de minería artesanal de oro con alta movilidad poblacional transfronteriza. Fuera de Crucitas se registran 5 casos en el foco Los Chiles (2 autóctonos y 3 introducidos en la localidad de El Parque, SE 41–42), 3 introducidos en la Región Chorotega (Nicoya y Hojancha, sin foco asignado),

1 autóctono en Matina (por P. falciparum) y 1 autóctono en Las Horquetas de Sarapiquí (sin foco asignado y con origen de infección no determinado).

Gráfico 4.
Casos de malaria por transmisión local según foco y clasificación epidemiológica, Costa Rica, 2026



Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud.

La Región Huetar Norte concentra 77 de los 99 casos confirmados del año, incluidos 18 de los 21 introducidos y 17 de los 19 autóctonos. En las demáregiones predominan los casos importados; la Región Chorotega registra 3 casos introducidos.

Tabla 1.
Casos confirmados de malaria por región de salud y clasificación epidemiológica, Costa Rica, 2026 (corte SE 42)

Región	Autóctono	Introducido	Importado	Recaída	En estudio	Total
Huetar Norte	17	18	35	0	7	77
Huetar Caribe	1	0	5	0	0	6
Central Sur	0	0	5	0	0	5
Chorotega	0	3	1	0	0	4
Pacífico Central	0	0	2	1	0	3
Central Norte	1	0	1	0	0	2
Central Occidente	0	0	1	0	0	1
Brunca	0	0	1	0	0	1
Total	**19**	**21**	**51**	**1**	**7**	**99**

Fuente: Coordinación de Malaria, DVS, Ministerio de Salud.

Tabla 2.
Casos confirmados de malaria según foco y clasificación epidemiológica, Costa Rica, 2026 (corte SE 42)

Foco	Autóctono	Introducido	Importado	Recaída	En estudio	Total
Crucitas	15	15	31	0	7	68
Los Chiles	2	3	1	0	0	6
Pital	0	0	2	0	0	2
Matina	1	0	0	0	0	1
Sin foco (no aplica)*	1	3	17	1	0	22
Total	**19**	**21**	**51**	**1**	**7**	**99**

Foco según registro de la investigación de caso. Transmisión local por especie: Crucitas 15 autóctonos *P. vivax*, 14 introducidos *P. vivax* y 1 introducido *P. falciparum*; Los Chiles 2 autóctonos y 3 introducidos *P. vivax*; Matina 1 autóctono *P. falciparum*; Las Horquetas 1 autóctono *P. vivax*; Chorotega 3 introducidos *P. vivax*. * Sin foco asignado: 1 autóctono de Las Horquetas, con origen de infección no determinado, y 3 introducidos de la Región Chorotega. Recaída: caso de la Región Pacífico Central (SE 41).
Fuente: Coordinación de Malaria, DVS, Ministerio de Salud.

Características de los casos de transmisión local

- **Sexo:** 30 hombres (75 %) y 10 mujeres (25 %).
- **Edad:** mediana de 33 años (rango 1–68); predominan los adultos jóvenes en edad productiva.
- **Ocupación:** 18 casos (45 %) se dedican a la minería artesanal (coligalleros y mineros), todos en el foco Crucitas.
- **Nacionalidad:** 27 nicaragüenses (67,5 %) y 13 costarricenses (32,5 %).
- **Gravedad:** 9 casos hospitalizados (22,5 %). Sin defunciones.
- **Especie parasitaria:** *P. vivax* en 38 casos (95 %) y *P. falciparum* en 2 (1 introducido en Crucitas y 1 autóctono en Matina).

Acciones de vigilancia y control

- **Búsqueda reactiva:** alrededor de los 40 casos de transmisión local se tomaron muestras a **1 961 personas** para detectar a tiempo otras infecciones; 8 resultaron positivas.
- **Búsqueda activa:** 23 de los 40 casos (58 %) se detectaron porque los equipos de salud salieron a buscarlos en la comunidad (búsqueda reactiva o proactiva), antes de que la persona consultara.
- **Investigación de cada caso** para identificar el lugar probable de infección y orientar las acciones de control en el foco.
- **Coordinación interinstitucional** entre el Ministerio de Salud, la CCSS y los colaboradores voluntarios (ColVol) de las comunidades.

Vigilancia diagnóstica

En 2026 se han realizado **169 183 pruebas diagnósticas de malaria**, más que las 162 241 de todo 2025. La prueba de diagnóstico rápido (PDR) representa el 96 % (161 752), seguida de la gota gruesa (7 253) y la PCR (178). El Ministerio de Salud aplicó 83 392 PDR, los colaboradores voluntarios (ColVol) 1 468 y la CCSS realizó 84 323 pruebas en sus establecimientos. Con 99 casos confirmados, se detecta aproximadamente 1 caso por cada 1 709 pruebas realizadas.

Tabla 3.
Pruebas diagnósticas de malaria realizadas según institución y tipo de prueba, Costa Rica, 2026 (corte SE 42)

Institución	PDR	Gota gruesa	PCR	Total
Ministerio de Salud	83 392	—	—	83 392
Colaboradores voluntarios (ColVol)	1 468	—	—	1 468
CCSS	76 892	7 253	178	84 323
Total	**161 752**	**7 253**	**178**	**169 183**

No incluye pruebas de G6PD (132 en la CCSS).
Fuente: Coordinación de Malaria, Ministerio de Salud; Caja Costarricense de Seguro Social.

En la CCSS, la mayor parte de las pruebas se procesa en laboratorio (44 247) y en los EBAIS (29 110). En la búsqueda comunitaria del Ministerio de Salud y ColVol, al corte de la SE 40 las regiones Brunca, Huetar Norte, Chorotega y Huetar Caribe concentraban el 90 % de las PDR aplicadas.

Casos importados y en estudio

Se registran **51 casos importados**; en 48 el lugar probable de infección es Nicaragua y 10 corresponden a recaídas por *P. vivax*. Además, 1 caso de la Región Pacífico Central (SE 41) se clasificó como recaída. **7 casos permanecen en estudio**, todos en el foco Crucitas (SE 35 a 41). La investigación de estos casos determinará dónde ocurrió la infección. En total se han confirmado 99 casos de malaria en 2026.

Tabla 4.
Casos importados según país probable de infección y especie, Costa Rica, 2026 (corte SE 42)

País probable de infección	Especie	Casos
Brasil	*P. vivax*	1
Etiopía	*P. vivax*	1
Nicaragua	Mixta (P. falciparum / P. vivax)	1
Nicaragua	*P. falciparum*	5
Nicaragua	*P. vivax*	42
Venezuela (recaída)*	*P. vivax*	1
Total		**51**

10 casos importados corresponden a recaídas por *P. vivax*. * Recaída en persona venezolana con antecedente de tránsito por el Darién.
Fuente: Coordinación de Malaria, Ministerio de Salud; Caja Costarricense de Seguro Social.

Recomendaciones a la población

- Si presenta **fiebre, escalofríos, sudoración o dolor de cabeza** y vive, trabaja o viajó a la zona norte del país o a un país con malaria, **acuda de inmediato al EBAIS o centro de salud** más cercano e indique dónde estuvo.
- La malaria **tiene cura**. Complete el tratamiento indicado, aunque se sienta mejor, y asista a los controles de gota gruesa.
- Protéjase de la picadura del mosquito *Anopheles*, sobre todo al atardecer y en la noche: use mosquitero, repelente y ropa de manga larga.
- Permita la visita de los equipos de salud y la toma de muestras en su comunidad; así se detectan los casos a tiempo.

Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica.

Acciones de control vectorial realizadas en el país a la semana epidemiológica 41

En la siguiente tabla se desglosan las acciones de control vectorial que se han realizado en la semana epidemiológica 41 del 2026, por el personal de Control de Vectores del país.

Tabla 1.
Costa Rica: Acciones de control vectorial en la semana epidemiológica 41.

Acciones realizadas	Total
Viviendas visitadas	**13 431**
Viviendas positivas	**714**
Depósitos tratados	**40 394**
Depósitos eliminados	**15 931**
Criaderos	**56 325**
Depósitos positivos	**721**
Viviendas fumigadas	**39 917**

Fuente: Consolidado Nacional de actividades de Control Vectorial.

Tabla 2
Costa Rica: Acciones acumuladas de control vectorial de la semana epidemiológica 1 a la 41.

Acciones realizadas	Total
Viviendas visitadas	**514 544**
Viviendas positivas	**24 789**
Depósitos tratados	**1 809 391**
Depósitos eliminados	**1 387 048**
Criaderos	**3 196 439**
Depósitos positivos	**56 663**
Viviendas fumigadas	**823 068**

Fuente: Consolidado Nacional de actividades de Control Vectorial.

Influenza y otras virosis respiratorias, IRAG, IRAS, ETI, neumonía y Covid-19

Resumen epidemiológico

IRA y ETI alcanzan la SE42, con 26 451 casos de IRAS y 331 de ETI; sus acumulados de 2026 son 1 144 696 y 12 460 casos, respectivamente. IRAG y neumonía alcanzan la SE42, con 34 y 43 casos en esa semana y acumulados de 7 811 y 6 532. Las cifras de la última semana disponible pueden aumentar por rezago de notificación y no se interpretan de manera aislada como aumento o disminución frente a la semana anterior.

El componente epidemiológico semanal del Hospital Nacional de Niños (HNN) alcanza la SE42, actualizado al 2 de noviembre de 2026. En laboratorio respiratorio, con corte en la SE41, 686 de 1 449 solicitudes válidas presentaron al menos un virus detectado, para una positividad global de 47,3 %.

Los casos nacionales de COVID-19 tienen último dato validado en la SE42, con 103 casos. La CCSS reportó al 3 de noviembre, correspondiente a la SE44, 7 pacientes positivos hospitalizados en salón y 0 en UCI. Para los fallecidos, el registro institucional de la CCSS reporta 3 fallecidos con COVID-19 según semana epidemiológica de egreso (2 en hospitalización y 1 en urgencias); este dato no representa la mortalidad nacional total.

Cuadro 1.
Costa Rica: Casos notificados en la última semana epidemiológica disponible y acumulados de IRAS, ETI, IRAG y neumonía, 2026.

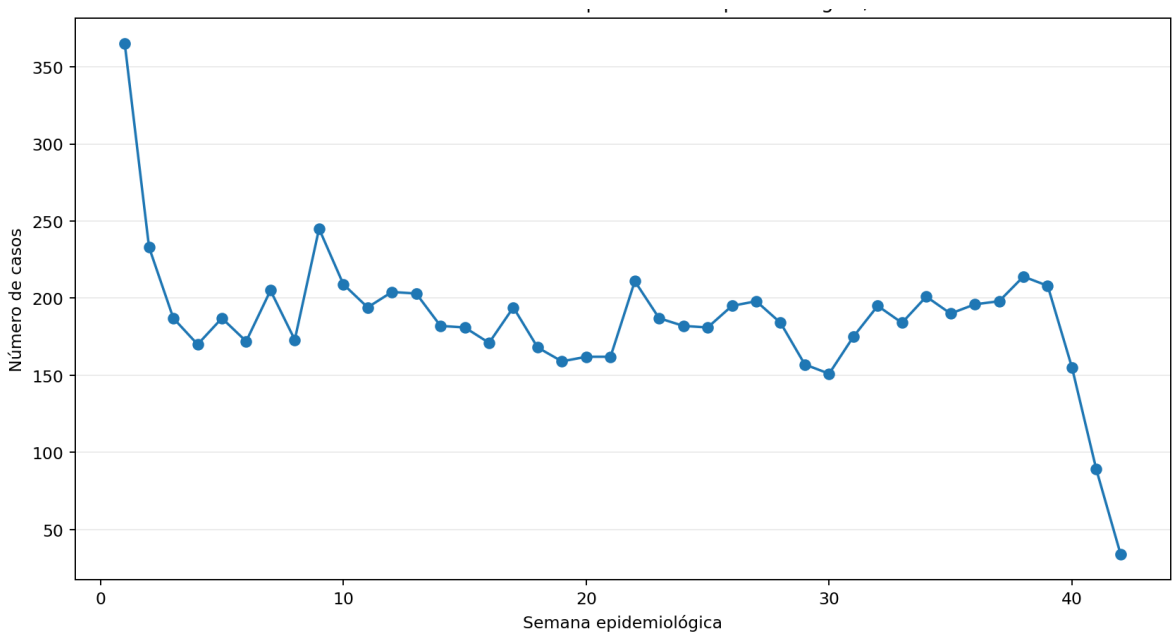
Evento	Última SE	Casos en la SE	Acumulado 2026
IRAS	SE42	26 451	1 144 696
ETI	SE42	331	12 460
IRAG	SE42	34	7 811
Neumonía	SE42	43	6 532

Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, 2026.

Infecciones respiratorias agudas graves (IRAG)

Según los registros de la boleta VE-01, a la SE42 se acumulan 7 811 casos de IRAG; en esa semana se notificaron preliminarmente 34 casos. La mayor carga acumulada se concentra en las personas de 75 años y más (1 892 casos), seguidas por los niños de 1 a 4 años (1 375) y los menores de 1 año (1 361). El dato de la SE42 es preliminar y puede aumentar por rezago de notificación.

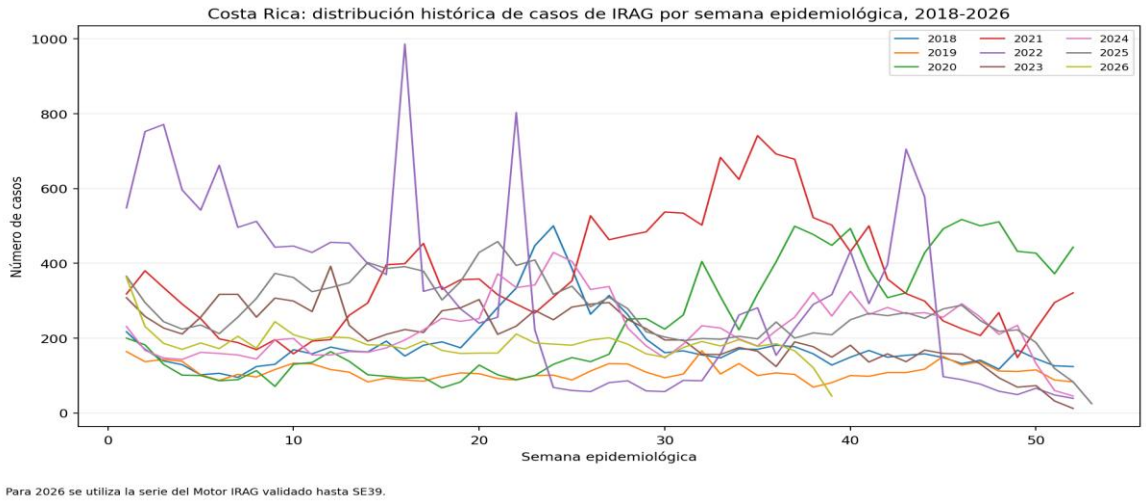
Gráfico 1.
Costa Rica: Casos de IRAG por semana epidemiológica, 2026.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud. Métrica: IRAG_LEGADO_NOTIFICACIONES.

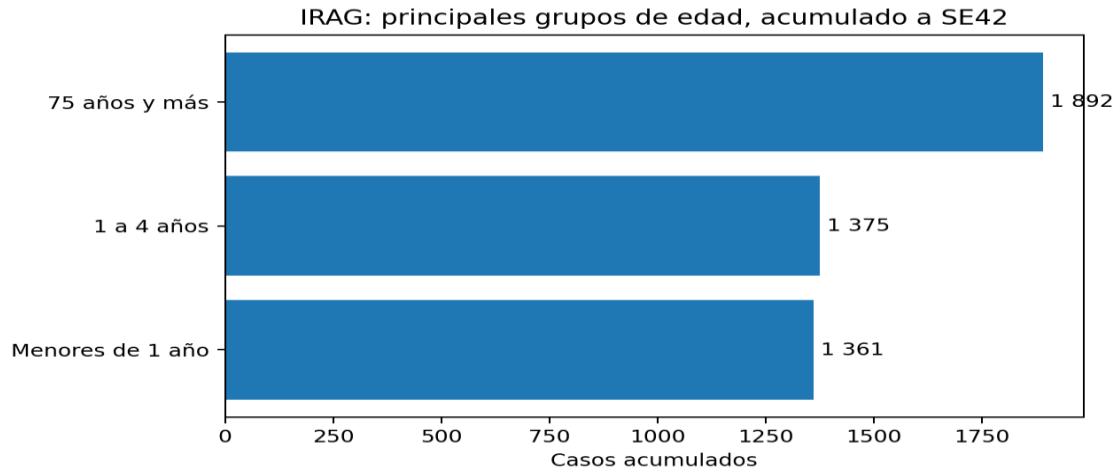
Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, 2026.

Gráfico 2.
Costa Rica: Distribución histórica de casos de IRAG por semana epidemiológica, 2018-2026.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, 2026.

Gráfico 3.
Costa Rica: Principales grupos de edad con mayor número acumulado de casos de IRAG a la SE42, 2026.

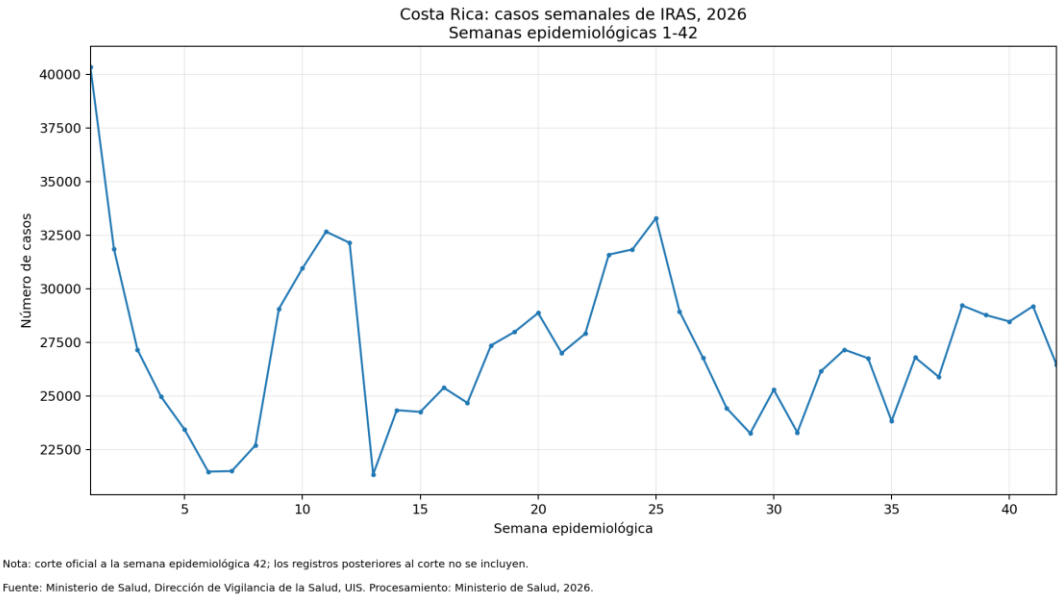


Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, 2026.

Infecciones respiratorias agudas superiores (IRAS)

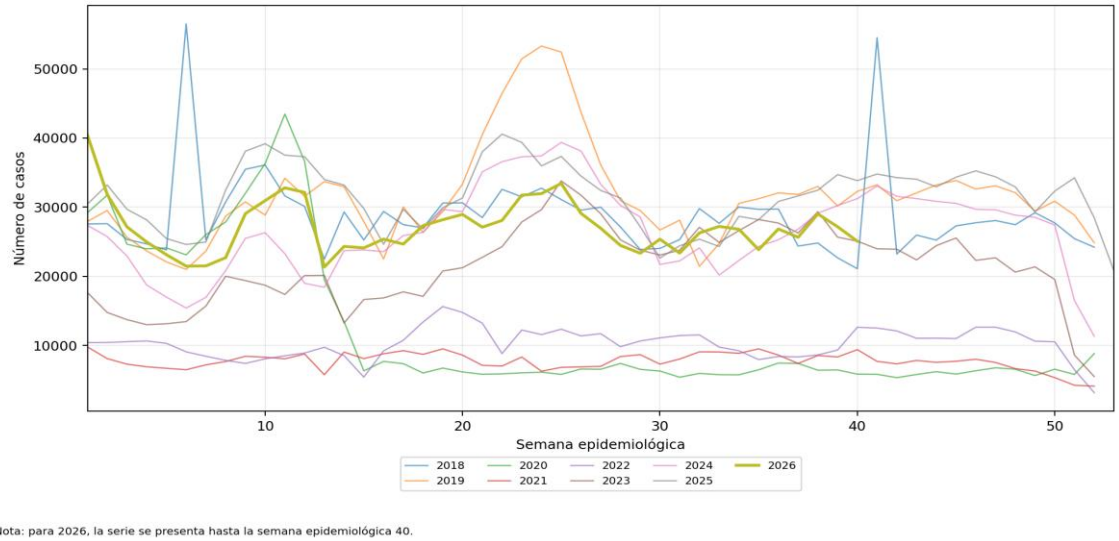
Según los registros de la boleta VE-02, a la SE42 se acumulan 1 144 696 casos de IRAS; en esa semana se registraron 26 451 casos. Los mayores acumulados corresponden a los niños de 1 a 4 años (129 913) y de 5 a 9 años (119 711). El dato de la SE42 puede aumentar por rezago de notificación.

Gráfico 4.
Costa Rica: Casos semanales de IRAS, 2026.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, 2026.

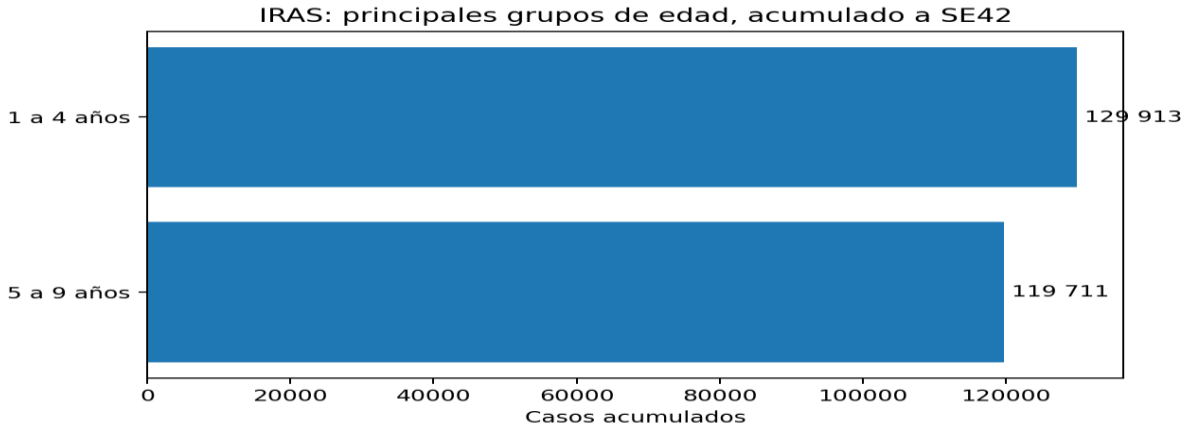
Gráfico 5.
Costa Rica: Distribución histórica semanal de IRAS, 2018-2026.



Nota: para 2026, la serie se presenta hasta la semana epidemiológica 40.

Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, 2026.

Gráfico 6.
Costa Rica: Principales grupos de edad con mayor número acumulado de casos de IRAS a la SE42, 2026.

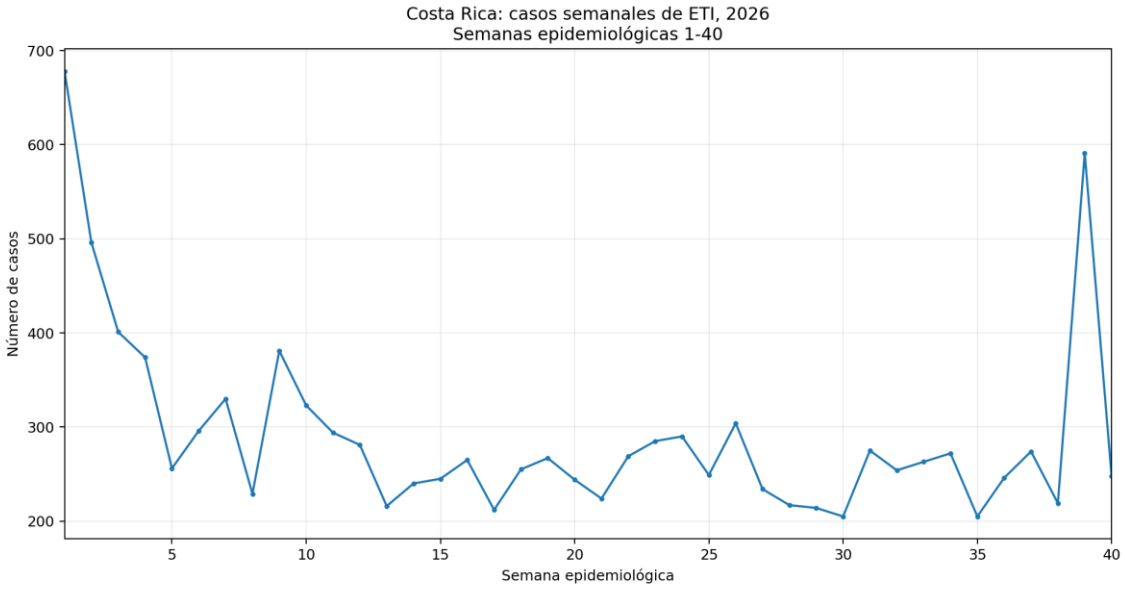


Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, 2026.

Enfermedad tipo influenza (ETI)

Según los registros de la boleta VE-02, a la SE42 se acumulan 12 460 casos de ETI; en esa semana se registraron 331 casos. Los mayores acumulados corresponden a los grupos de 25 a 29 años (1 109 casos) y 30 a 34 años (1 090). El dato de la SE42 puede aumentar por rezago de notificación y debe interpretarse conjuntamente con la circulación de virus respiratorios identificada por laboratorio.

Gráfico 7.
Costa Rica: Casos semanales de ETI, 2026. Serie gráfica disponible en el archivo base hasta SE40.

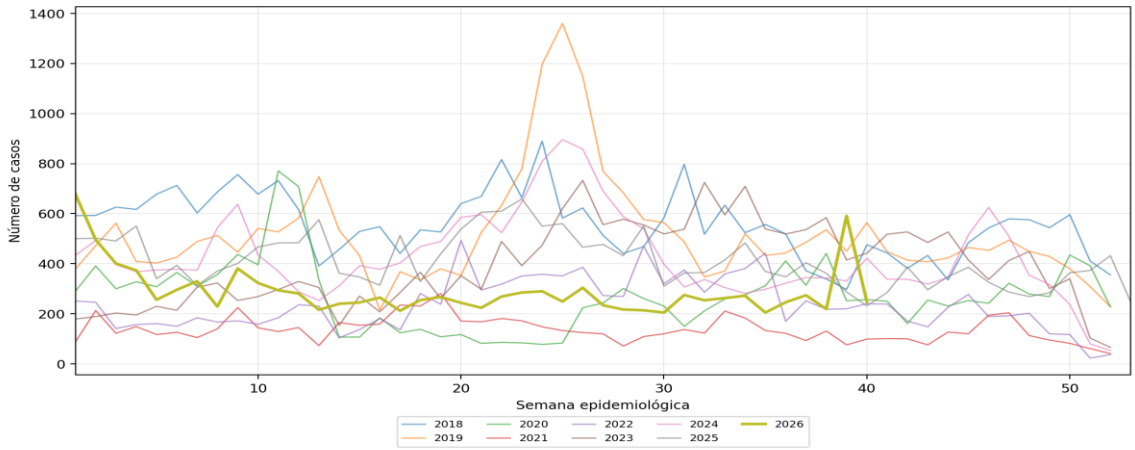


Nota: corte oficial a la semana epidemiológica 40; los registros posteriores al corte no se incluyen.

Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS. Procesamiento: Ministerio de Salud, 2026.

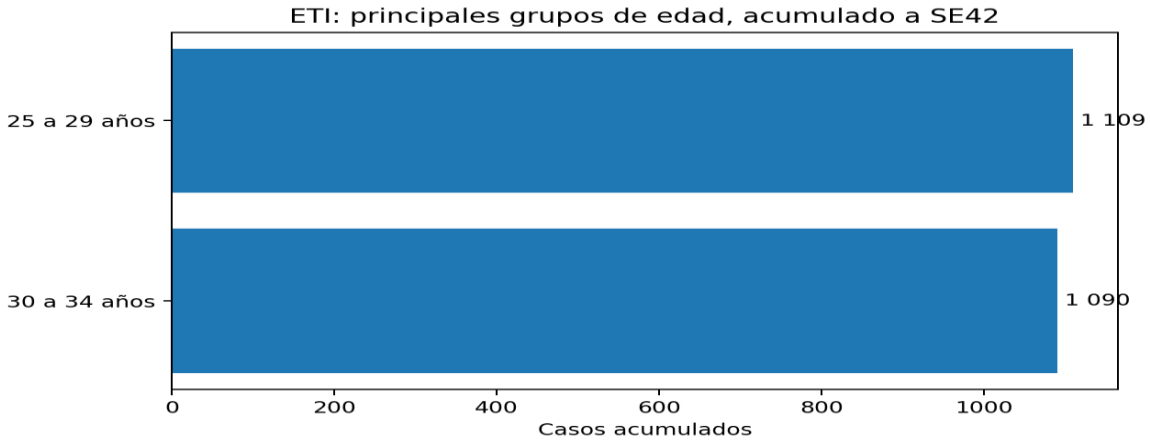
Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, 2026.

Gráfico 8.
Costa Rica: Distribución histórica semanal de ETI, 2018-2026.



Nota: el archivo base del boletín conserva la serie gráfica de ETI hasta la SE40. Los valores actualizados de SE42 (331 casos; acumulado 12 460) se presentan en el texto y no se extrapolan gráficamente.
Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, 2026.

Gráfico 9.
Costa Rica: Principales grupos de edad con mayor número acumulado de casos de ETI a la SE42, 2026.

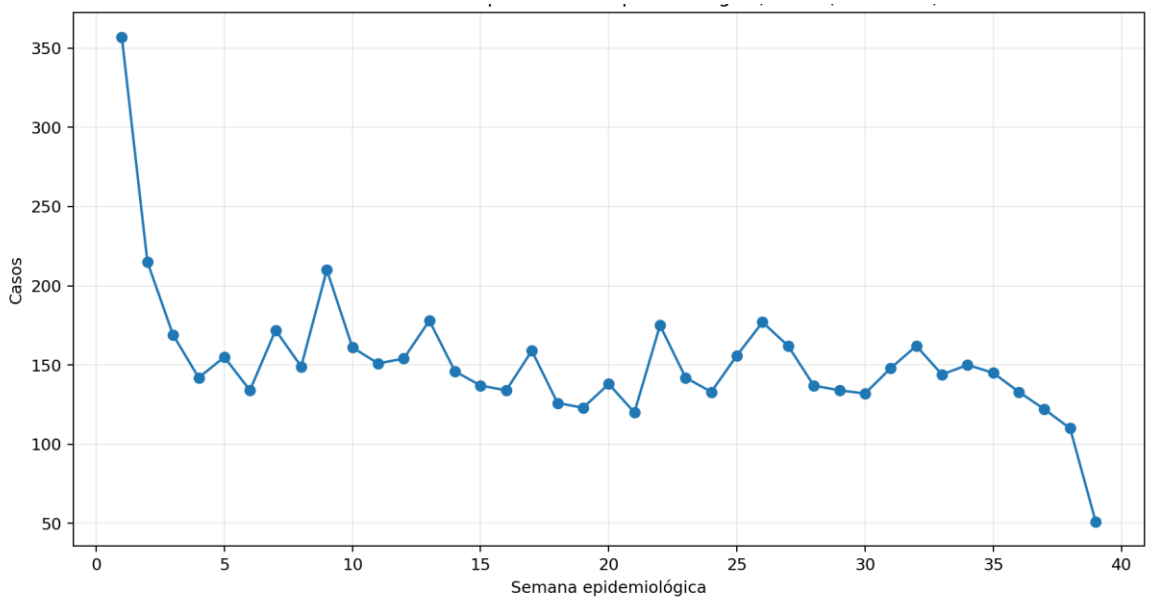


Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, 2026.

Neumonía

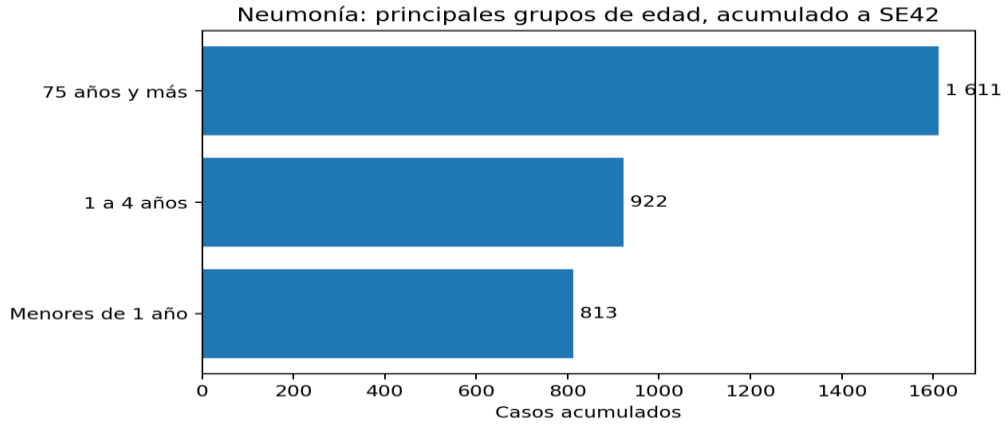
A la SE42 se registran 6 532 casos acumulados de neumonía; en esa semana se notificaron 43 casos. La mayor carga acumulada corresponde a las personas de 75 años y más (1 611 casos), seguidas por los niños de 1 a 4 años (922) y los menores de 1 año (813). El dato de la SE42 es preliminar y puede aumentar por rezago de notificación.

Gráfico 10.
Costa Rica: Neumonía notificada por semana epidemiológica, 2026. Serie gráfica disponible en el archivo base hasta SE39.



Nota: el archivo base del boletín conserva la serie gráfica de neumonía hasta la SE39. Los valores actualizados de SE42 (43 casos; acumulado 6 532) se presentan en el texto y no se extrapolan gráficamente.
Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, 2026.

Gráfico 11.
Costa Rica: Principales grupos de edad con mayor número acumulado de casos de neumonía a la SE42, 2026.

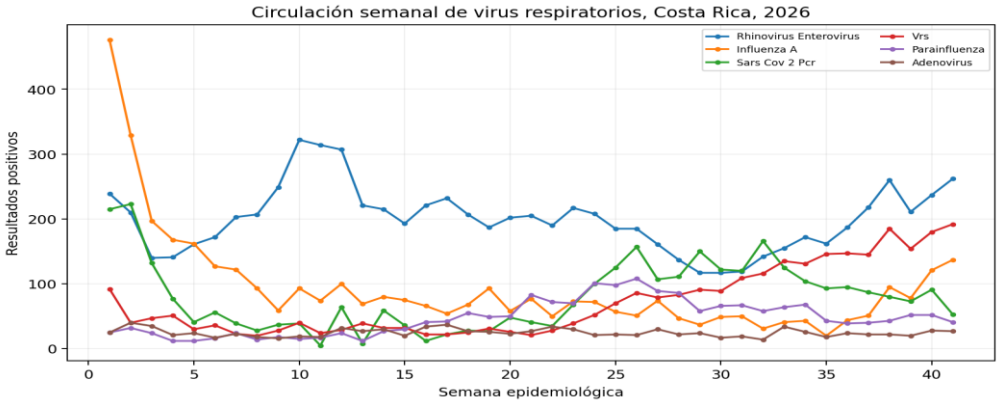


Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, 2026.

Vigilancia de laboratorio de virus respiratorios

Con corte en la SE41 se analizaron 1 449 solicitudes válidas, de las cuales 686 presentaron al menos un virus detectado, para una positividad global de 47,3 %. Los agentes con mayor número de detecciones fueron rinovirus/enterovirus (262) y virus respiratorio sincitial (192). La positividad global se calcula por solicitud.

Gráfico 12.
Costa Rica: Circulación semanal de virus respiratorios, 2026.



Fuente: Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), laboratorio de virus respiratorios, 2026.

Situación pediátrica - Hospital Nacional de Niños

La situación pediátrica integra el componente epidemiológico semanal y el seguimiento operativo diario del HNN. Para este boletín se presentan los indicadores epidemiológicos semanales validados con corte SE42. Lo s datos se encuentran actualizados al 02/11/2026.

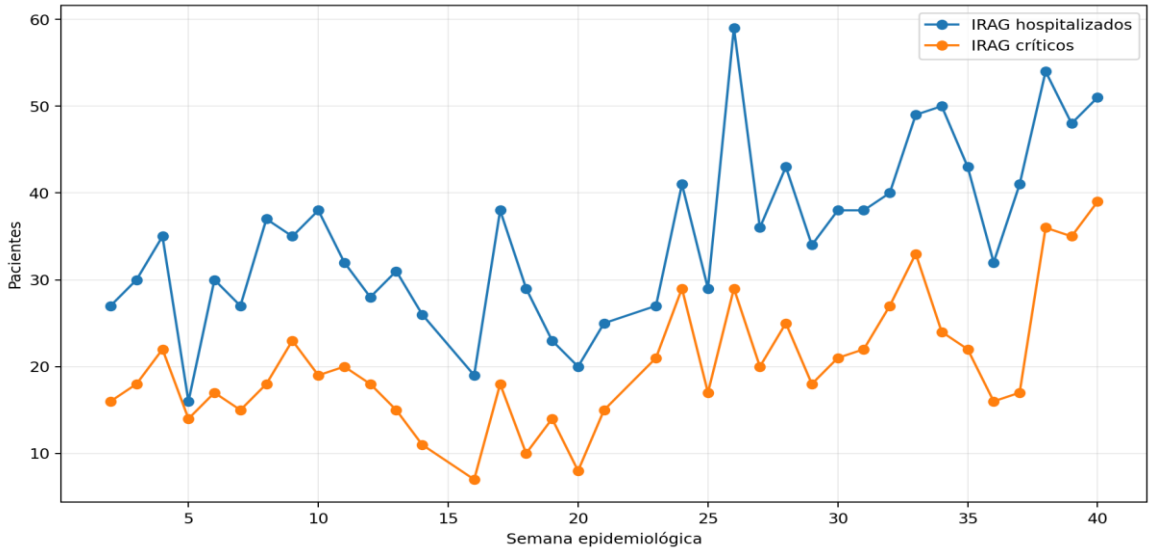
Cuadro 2.
Costa Rica: Indicadores epidemiológicos respiratorios, Hospital Nacional de Niños, SE42 de 2026.

Indicador	Dato
Hospitalizados por IRAG	57
IRAG críticos	42
Proporción crítica	73,7 %
Muestras respiratorias procesadas	182
Muestras positivas	112
Positividad	62,0 %
Fallecimientos acumulados por IRAG	19

Fuente: Hospital Nacional de Niños, CCSS. Vigilancia epidemiológica semanal, SE42 de 2026.

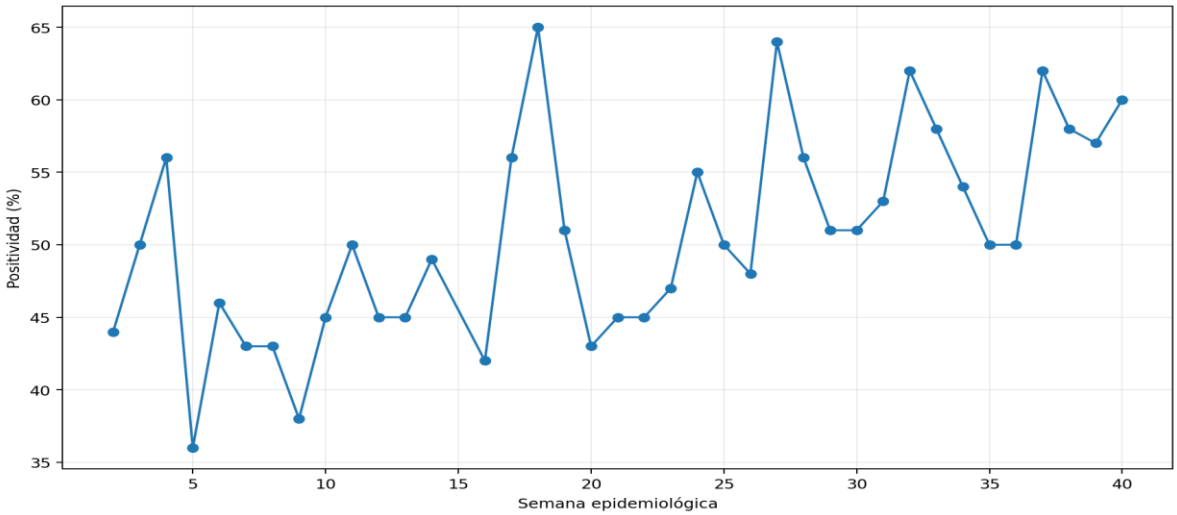
En la SE42 se registraron 57 hospitalizados por IRAG, 42 de ellos en condición crítica (73,7 %). Se procesaron 182 muestras respiratorias, de las cuales 112 resultaron positivas (62,0 %). La mortalidad acumulada por IRAG alcanzó 19 fallecimientos al 29/10/2026.

Gráfico 13.
Costa Rica: IRAG hospitalizados y críticos por semana epidemiológica, Hospital Nacional de Niños, 2026.



Fuente: Hospital Nacional de Niños, CCSS. Vigilancia epidemiológica semanal, 2026.

Gráfico 14.
Costa Rica: Positividad de muestras respiratorias por semana de informe, Hospital Nacional de Niños, 2026.

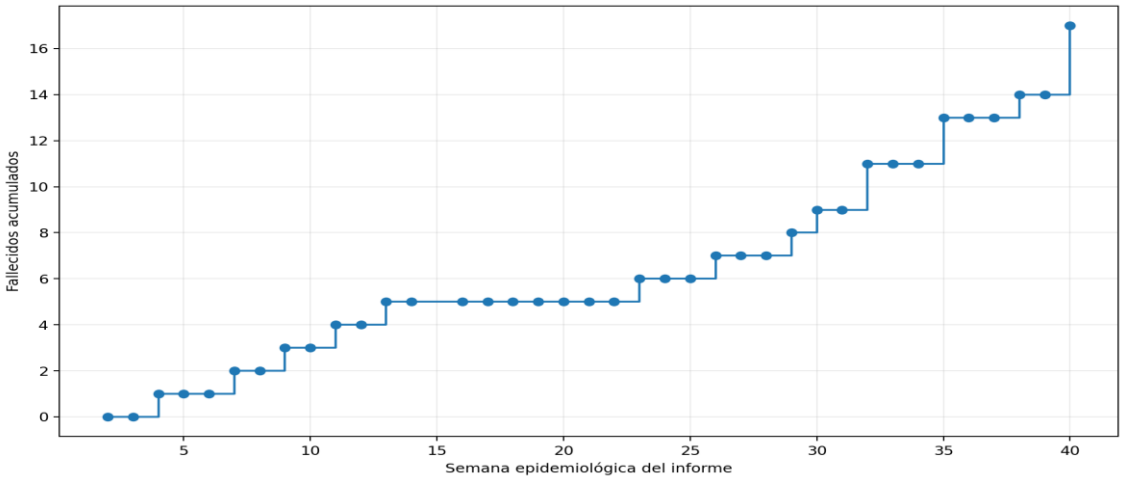


Fuente: Hospital Nacional de Niños, CCSS. Vigilancia epidemiológica semanal, 2026.
Mortalidad acumulada por IRAG - Hospital Nacional de Niños

Al 29 de octubre de 2026, el Hospital Nacional de Niños reporta 19 fallecimientos acumulados por IRAG. La serie corresponde al acumulado informado en los reportes epidemiológicos semanales.

Gráfico 15.

Costa Rica: Fallecimientos acumulados por IRAG según semana de informe, Hospital Nacional de Niños, 2026.

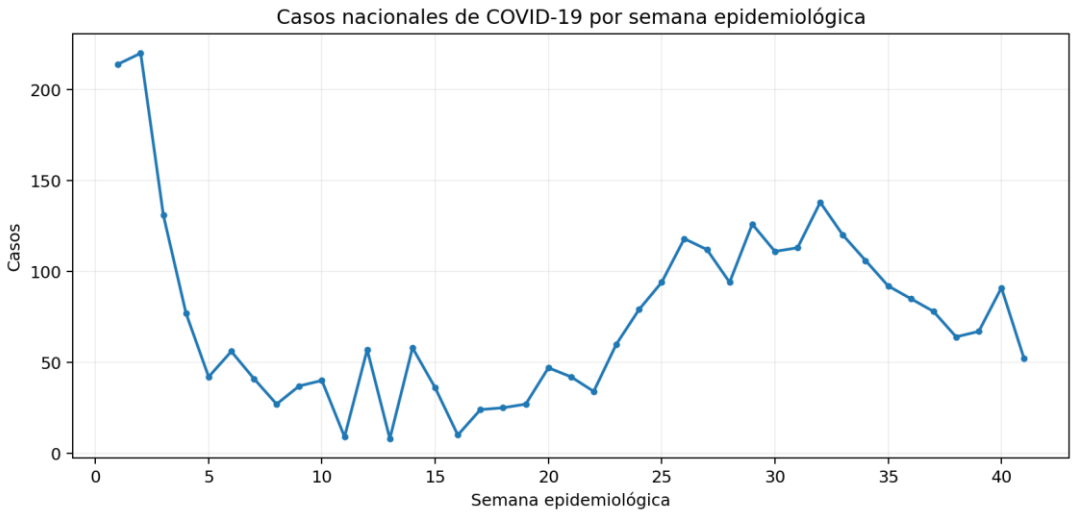


Fuente: Hospital Nacional de Niños, CCSS. Vigilancia epidemiológica semanal, SE42 de 2026.

COVID-19

Los casos nacionales de COVID-19 cuentan con último dato validado en la SE42, con 103 casos registrados. La curva semanal completa actualizada no se reconstruye en esta edición a partir de valores parciales: se conserva la última serie gráfica validada disponible en el archivo base y el dato SE42 se presenta explícitamente en el texto.

Gráfico 16.
Costa Rica: Casos nacionales de COVID-19 por semana epidemiológica, 2026. Serie gráfica base hasta SE41; último dato validado SE42 = 103.



Fuente: Vigilancia nacional de COVID-19, sector público y privado. Ministerio de Salud, 2026.

Hospitalización y fallecidos registrados por la CCSS

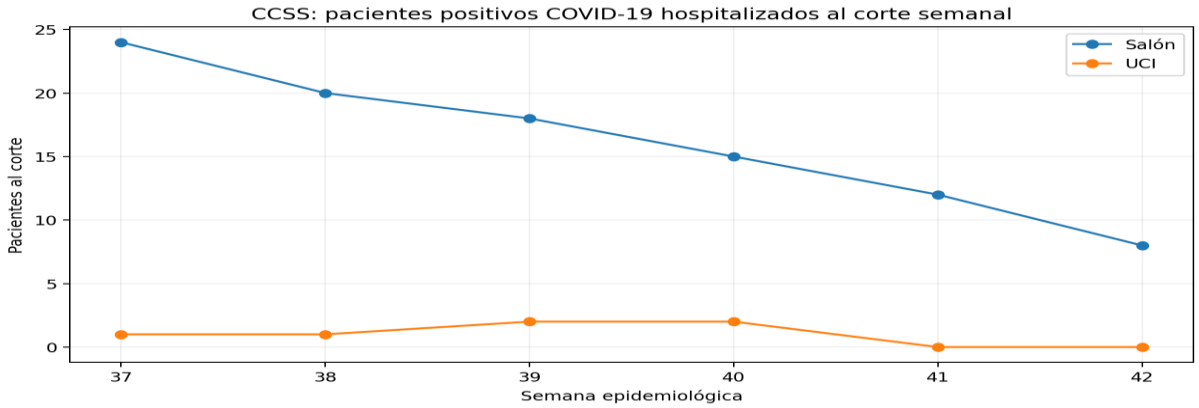
Al corte del 3 de noviembre de 2026, correspondiente a la SE44, la CCSS reportó 7 pacientes positivos hospitalizados en salón y 0 pacientes en UCI. El registro institucional de la CCSS reporta 3 fallecidos con COVID-19 según semana epidemiológica de egreso: 2 en hospitalización y 1 en urgencias. Estos fallecidos corresponden al registro hospitalario institucional de la CCSS y no representan la mortalidad nacional total por COVID-19.

Cuadro 3.
Costa Rica: Pacientes positivos por COVID-19 hospitalizados al corte semanal, CCSS, 2026.

Corte	Semana	Salón	UCI
26/09/2026	SE38	20	1
03/10/2026	SE39	18	2
10/10/2026	SE40	15	2
17/10/2026	SE41	12	0
03/11/2026	SE44	7	0

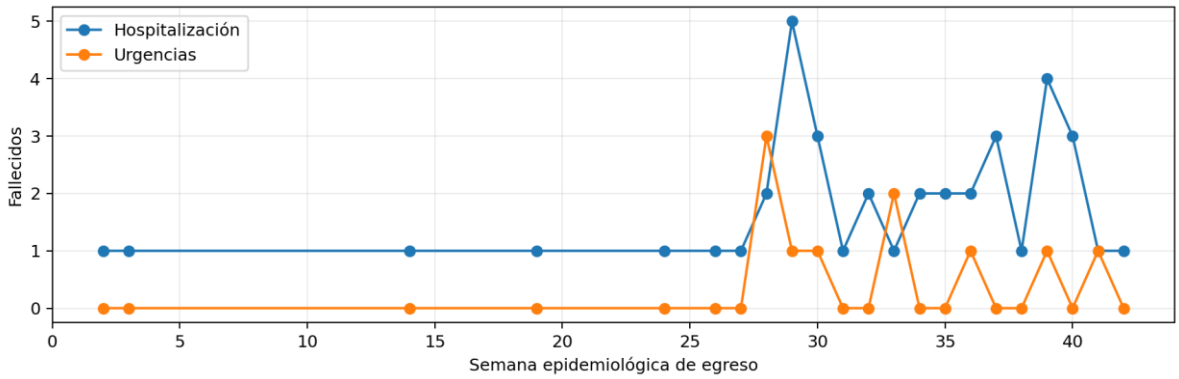
Fuente: Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Power BI institucional, 2026.

Gráfico 17.
Costa Rica: Pacientes positivos por COVID-19 hospitalizados en salón y UCI según fecha de corte, CCSS, 2026.



Fuente: Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Power BI institucional. Corte consultado el 03/11/2026.

Gráfico 18.
Costa Rica: Fallecidos con COVID-19 según semana epidemiológica de egreso y servicio, CCSS, 2026.

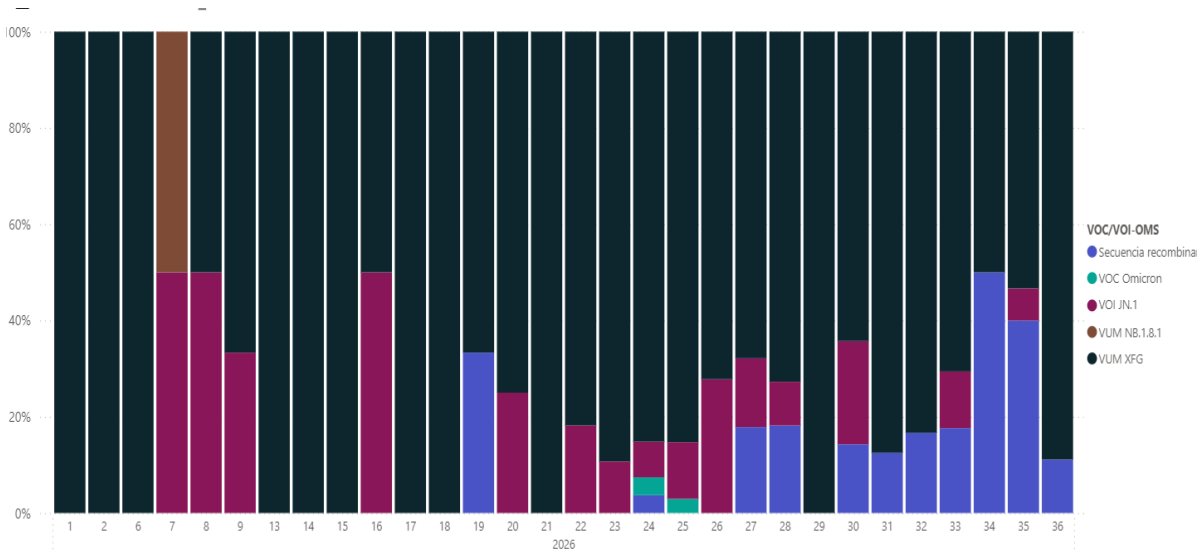


Fuente: Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Power BI institucional. Corte consultado el 03/11/2026.

Vigilancia genómica de SARS-CoV-2

El último corte visual documentado disponible del panel de vigilancia genómica de INCIENSA alcanza la SE36 de 2026. Debido a que este componente presenta un corte anterior al resto de la vigilancia respiratoria incluida en este boletín, sus resultados se presentan como información complementaria y no deben extrapolarse para describir la circulación de linajes en semanas posteriores.

Gráfico 19.
Costa Rica: Proporción de linajes identificados según semana y año epidemiológico para VOC/VOI/VUM, 2026.



Fuente: INCIENSA, vigilancia genómica de SARS-CoV-2, 2026.

Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) al 2 de noviembre 2026.

Al cierre de la SE 42 del 2026 se contabilizan 376 017 casos de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) correspondientes a las semanas epidemiológicas (SE) de la 1 a la 42. Los mayores registros semanales del año se observaron en la SE 12 (13 282 casos), SE 22 (12 224), SE 14 (12 057) y SE 17 (11 900). En las semanas más recientes se registraron 6 449 casos en la SE 39, 6 225 en la SE 40, 6 791 en la SE 41 y 5 003 casos preliminares en la SE 42.

Las cifras de las semanas epidemiológicas más recientes deben interpretarse con cautela debido al rezago habitual en la notificación y consolidación de los registros del sistema de vigilancia. Los datos recientes pueden encontrarse parcialmente subestimados y modificarse conforme se incorporen notificaciones adicionales.
De acuerdo con el análisis del canal endémico, durante 2026 se han presentado varias semanas con valores superiores a los esperados. Para la SE 42 se registran preliminarmente 5 003 casos, cifra que se mantiene ligeramente por encima del umbral de alerta estimado para esa semana. Este hallazgo requiere seguimiento considerando el carácter preliminar de los datos y el rezago de notificación.

El comportamiento de la EDA puede estar influenciado por factores ambientales, climáticos y conductuales, entre ellos las condiciones de manipulación y conservación de los alimentos, la calidad y disponibilidad del agua, las prácticas de higiene y los patrones de movilidad e interacción de la población. Estos factores deben analizarse juntamente con la tendencia temporal, la distribución territorial y la ocurrencia de brotes.

En este contexto, se mantiene la vigilancia epidemiológica intensificada de la EDA, con seguimiento continuo de la tendencia temporal, la distribución territorial y la ocurrencia de brotes, con el propósito de identificar oportunamente cambios relevantes o concentraciones inusuales de casos o desviaciones respecto al comportamiento esperado.

Contexto climático 2026 y EDA

Las condiciones climáticas pueden influir de manera importante en el comportamiento de la Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), al modificar la temperatura ambiental, los patrones de precipitación, la disponibilidad y calidad del agua y las condiciones de conservación de los alimentos.

Durante 2026, los mayores registros semanales de EDA se observaron en las SE 12, 22, 14 y 17. Estos incrementos se presentaron en distintos momentos del año y deben analizarse de manera integrada con las condiciones de temperatura, precipitación, humedad, disponibilidad y calidad del agua, así como con las prácticas de manipulación y conservación de alimentos. La coincidencia temporal con variables climáticas puede ser epidemiológicamente relevante, pero por sí sola no permite establecer una relación causal.

Las temperaturas elevadas pueden favorecer la proliferación y supervivencia de microorganismos en alimentos y agua, así como acelerar el deterioro de productos perecederos cuando existen condiciones inadecuadas de refrigeración, almacenamiento o manipulación. De forma paralela, las variaciones en las lluvias y en los sistemas de abastecimiento pueden afectar la disponibilidad y calidad microbiológica del agua, especialmente en comunidades con interrupciones del servicio, almacenamiento inadecuado o acceso limitado a fuentes seguras.
A estos factores ambientales se suman prácticas de higiene y manipulación de alimentos que pueden incrementar el riesgo de transmisión, entre ellas el lavado insuficiente de manos, la contaminación cruzada y las deficiencias en la preparación y conservación de los alimentos.

En conjunto, la interacción entre temperatura, precipitación, humedad, disponibilidad de agua, inocuidad de los alimentos y prácticas de higiene puede generar condiciones favorables para la transmisión de agentes causantes de EDA. Por esta razón, el monitoreo de las variables climáticas constituye un componente complementario de la vigilancia epidemiológica, al contribuir a identificar períodos de mayor riesgo y orientar oportunamente las acciones de prevención y control.

Canal Endémico EDA

Entre las SE 30 y 42 se registraron 89 388 casos de EDA, con un promedio aproximado de 6 876 casos por semana. En este período se observa una tendencia general descendente, aunque con fluctuaciones intersemanales, pasando de 7 321 casos en la SE 30 a 5 003 en la SE 42, lo que representa una reducción observada de 31,7%.

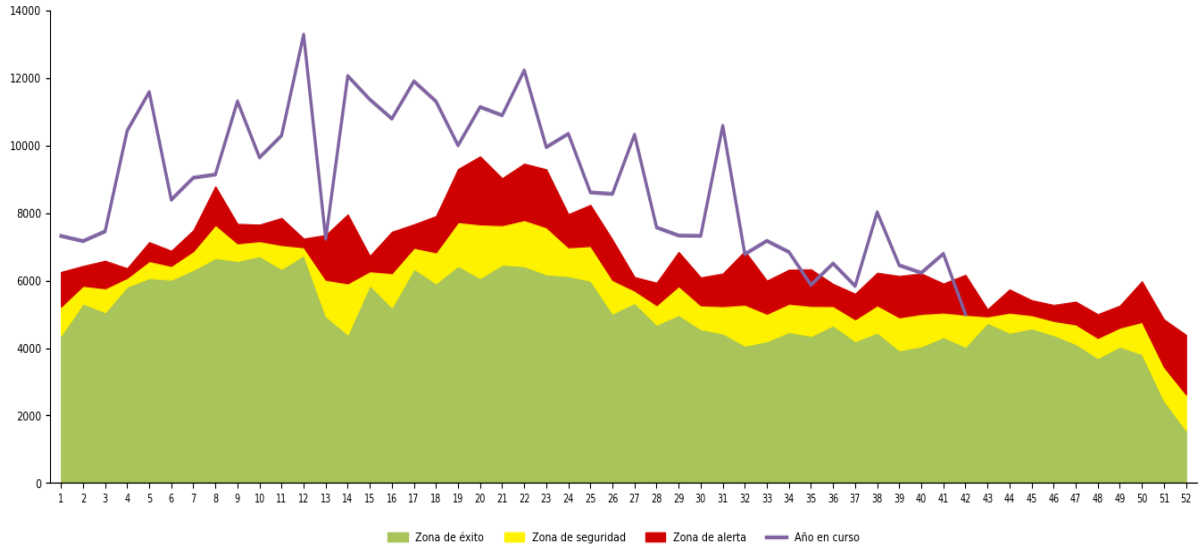
Los datos correspondientes a las semanas epidemiológicas más recientes son preliminares y se encuentran en proceso de consolidación, por lo que la posición de la curva dentro del canal endémico puede modificarse conforme se incorporen registros adicionales.

El canal endémico permite comparar el comportamiento observado en 2026 con los límites históricos esperados para la EDA, distribuidos en zona de éxito, zona de seguridad y zona de alerta.
Durante 2026, la curva ha presentado variaciones importantes y en diferentes momentos se ha ubicado por encima de los valores esperados, con ingreso a la zona de alerta. En la SE 42 el valor observado de 5 003 casos se mantiene ligeramente por encima del umbral de alerta del canal endémico.
Desde la SE 30 se observa una tendencia general descendente, aunque con fluctuaciones y aumentos intersemanales, particularmente en las SE 31, 38 y 41. La SE 42 continúa requiriendo seguimiento por ubicarse ligeramente por encima del umbral de alerta. Debido al rezago de notificación de las semanas más recientes, es necesario esperar la consolidación de los datos antes de determinar si la reducción representa un cambio sostenido en la tendencia.

En términos generales, el canal endémico evidencia que durante 2026 se han presentado períodos de elevada actividad de EDA, alternados con semanas de menor incidencia. La información disponible hasta la SE 42 muestra una tendencia general descendente reciente, pero con fluctuaciones y valores que aún requieren vigilancia estrecha frente a los límites históricos esperados.

El análisis continuo del canal endémico permite identificar oportunamente desviaciones respecto al comportamiento histórico y orientar la vigilancia hacia períodos o territorios que requieran investigación adicional.

Gráfico 1
Costa Rica. Canal endémico para EDA por semana epidemiológica hasta la SE 42. Años 2018- 2026 *

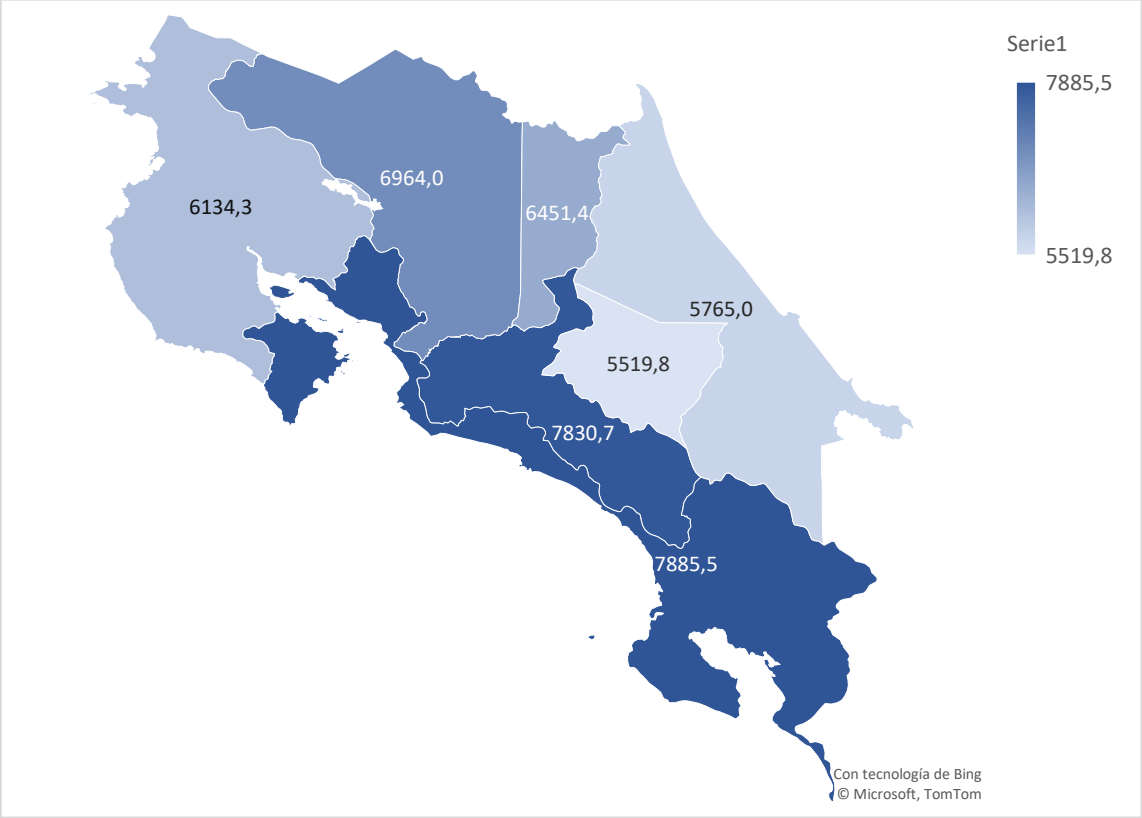


Fuente: Datos preliminares, Dirección Vigilancia de la Salud. Ministerio de Salud.
*Nota: Se excluyen del 2020 y 2021 por la pandemia COVID-19 y 2022 por hackeo de la CCSS.

Distribución territorial de la EDA

La tasa acumulada nacional de EDA hasta la SE 42 de 2026 se estima en 7 207,1 casos por 100 000 habitantes. A nivel provincial, Puntarenas (8 239,2) y San José (8 213,0) presentan tasas superiores al promedio nacional, mientras que Alajuela (6 964,0), Heredia (6 801,9), Guanacaste (6 347,0), Limón (5 975,8) y Cartago (5 721,7) se mantienen por debajo de este valor.

Figura 1
Costa Rica. Tasa de Incidencia de EDA, según provincia. SE 42, 2026



Fuente: Datos preliminares. Dirección Vigilancia de la Salud. Ministerio de Salud.

El análisis por región de salud evidencia una mayor concentración de la enfermedad en la Región Pacífico Central, con una tasa aproximada de 10 469,4 casos por 100 000 habitantes, seguida de la Región Central Sur, con 8 561,0 por 100 000 habitantes. Posteriormente se ubican la Región Central Norte (7 037,3), Huetar Norte (6 939,9), Chorotega (6 424,2), Huetar Caribe (5 975,8), Central Este (5 848,3), Central Occidente (5 543,1) y Brunca (4 974,8).

Este comportamiento muestra diferencias territoriales importantes en la incidencia acumulada de EDA y permite identificar regiones prioritarias para el seguimiento epidemiológico y el análisis de posibles factores locales asociados con la mayor carga de enfermedad.

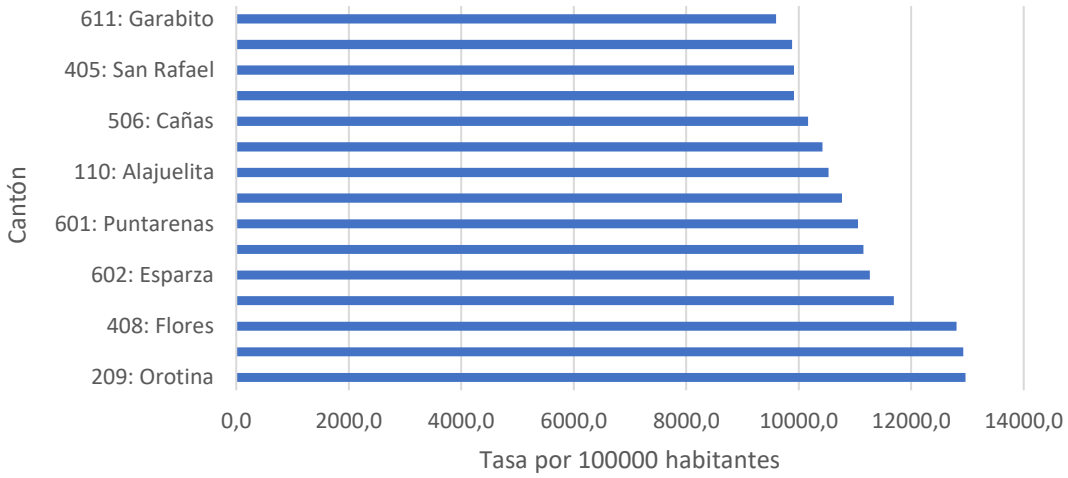
Cantones con mayor incidencia

La distribución cantonal evidencia diferencias importantes en la incidencia acumulada de EDA. Orotina presenta la tasa más alta del país, con 12 967,6 casos por 100 000 habitantes, seguido de Vázquez de Coronado (12 927,7), Flores (12 804,0), Montes de Oro (11 691,1) y Esparza (11 262,9). Estas tasas se encuentran entre las más elevadas observadas durante el período analizado.

También presentan tasas superiores a 10 000 casos por 100 000 habitantes los cantones de Mora (11 148,5), Puntarenas (11 051,3), Goicoechea (10 769,6), Alajuelita (10 532,4), San José (10 424,9) y Cañas (10 167,9). Asimismo, destacan Nandayure (9 915,8), San Rafael (9 913,6), Aserrí (9 879,2), Garabito (9 595,8), Santa Cruz (9 523,5) y El Guarco (9 315,7).

La distribución territorial confirma que la carga de EDA no es homogénea entre los cantones. En total, 11 cantones presentan tasas superiores a 10 000 casos por 100 000 habitantes: Orotina, Vázquez de Coronado, Flores, Montes de Oro, Esparza, Mora, Puntarenas, Goicoechea, Alajuelita, San José y Cañas. La presencia de cantones con incidencias elevadas en diferentes regiones del país evidencia la necesidad de mantener un seguimiento territorial diferenciado y profundizar en el análisis de los factores epidemiológicos, ambientales y sociales asociados.

Gráfico 2
Costa Rica. Cantones con mayor tasa acumulada de EDA, SE 42, 2026



Fuente: Datos preliminares. Dirección Vigilancia de la Salud. Ministerio de Salud.

Desde la perspectiva de vigilancia epidemiológica, estos hallazgos respaldan la necesidad de priorizar el análisis de los territorios con tasas persistentemente elevadas, integrando información sobre brotes, abastecimiento y calidad del agua, establecimientos de alimentos, condiciones ambientales, movilidad poblacional y otros determinantes locales que permitan explicar las diferencias observadas.

Distribución por edad y sexo

La distribución por edad mantiene un patrón bimodal, con las tasas más elevadas en la niñez temprana y en los adultos jóvenes. La mayor tasa se registra en el grupo de 20 a 24 años, con 12 498,3 casos por 100 000 habitantes, seguido por los grupos de 25 a 29 años (11 347,6), 1 a 4 años (10 933,7) y menores de 1 año (10 779,7). Este comportamiento concentra la atención en dos grupos de interés epidemiológico: los menores de cinco años, por su vulnerabilidad ante las complicaciones asociadas a los cuadros gastrointestinales, y los adultos jóvenes de 20 a 29 años, quienes presentan las tasas de incidencia más elevadas del período analizado.

A partir de los 40 años se observa una disminución general de las tasas de incidencia en comparación con los grupos de adultos jóvenes. Este patrón refuerza la importancia de mantener acciones de vigilancia y prevención dirigidas especialmente a la niñez temprana y a la población adulta joven, sin descuidar a los grupos de mayor edad por su riesgo de complicaciones.
En términos absolutos, el mayor número de casos se concentra en los grupos de 20 a 24 años (47 320 casos) y 25 a 29 años (46 792), seguidos por los grupos de 30 a 34 años (39 816) y 35 a 39 años (39 727).
De acuerdo con los datos disponibles, se registran 203 274 casos en mujeres y 172 478 en hombres, además de 265 registros clasificados en categoría desconocida. Por grupo de edad, el número de casos es mayor en hombres en los grupos menores de 1 año, 1 a 4 años, 5 a 9 años y 10 a 14 años; a partir de los 15 años predominan los casos registrados en mujeres.

Recomendaciones a la población

Ante la ocurrencia de casos y brotes de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), el Ministerio de Salud recomienda reforzar las medidas de prevención relacionadas con la higiene, el consumo de agua segura y la manipulación adecuada de los alimentos.

Se recomienda acudir oportunamente a los servicios de salud ante la presencia de diarrea, vómitos, fiebre, dolor abdominal, signos de deshidratación o sangre en las heces, especialmente cuando varias personas presentan síntomas similares después de consumir los mismos alimentos o agua.

Asimismo, se insta a la población a informar al Ministerio de Salud sobre situaciones que puedan representar un riesgo sanitario, como enfermedad de varias personas asociada a un mismo establecimiento o alimento, deficiencias de higiene, problemas de refrigeración, alimentos en mal estado o prácticas inadecuadas de manipulación. La notificación temprana facilita la investigación de brotes y la aplicación oportuna de medidas de control.

Para prevenir la EDA:
Mantener un adecuado lavado de manos.
Consumir agua segura.
Cocinar adecuadamente los alimentos.
Mantener una correcta refrigeración y conservación.
Evitar la contaminación cruzada entre alimentos crudos y preparados.
No consumir alimentos en mal estado o de procedencia dudosa.

Conclusión EDA

A la SE 42 de 2026, la EDA continúa representando una carga relevante para la salud pública en Costa Rica, con 376 017 casos acumulados y una tasa nacional estimada de 7 207,1 casos por 100 000 habitantes. Entre las SE 30 y 42 se observa una tendencia general descendente, con una reducción de 31,7% entre la SE 30 y la SE 42, aunque con fluctuaciones intersemanales. Esta tendencia debe interpretarse con cautela por el rezago habitual en la consolidación de los registros y porque la SE 42 se mantiene ligeramente por encima del umbral de alerta del canal endémico.

El seguimiento epidemiológico debe orientarse a confirmar la evolución de la tendencia y vigilar particularmente los territorios con mayor incidencia. El Pacífico Central y la Región Central Sur presentan las tasas regionales más elevadas, mientras que a nivel cantonal destacan Orotina, Vázquez de Coronado, Flores, Montes de Oro, Esparza, Mora, Puntarenas, Goicoechea, Alajuelita, San José y Cañas, todos con tasas superiores a 10 000 casos por 100 000 habitantes.

Resulta fundamental reforzar las medidas de prevención, especialmente el lavado adecuado de manos, el consumo de agua segura, la correcta cocción y conservación de los alimentos y la prevención de la contaminación cruzada.

En este contexto, la aplicación oportuna del Protocolo de Vigilancia de Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA), junto con la vigilancia activa, la investigación de campo y la respuesta temprana ante alertas locales, constituye un elemento clave para identificar fuentes de transmisión, implementar medidas de control y reducir el impacto de la enfermedad en las poblaciones y territorios más afectados

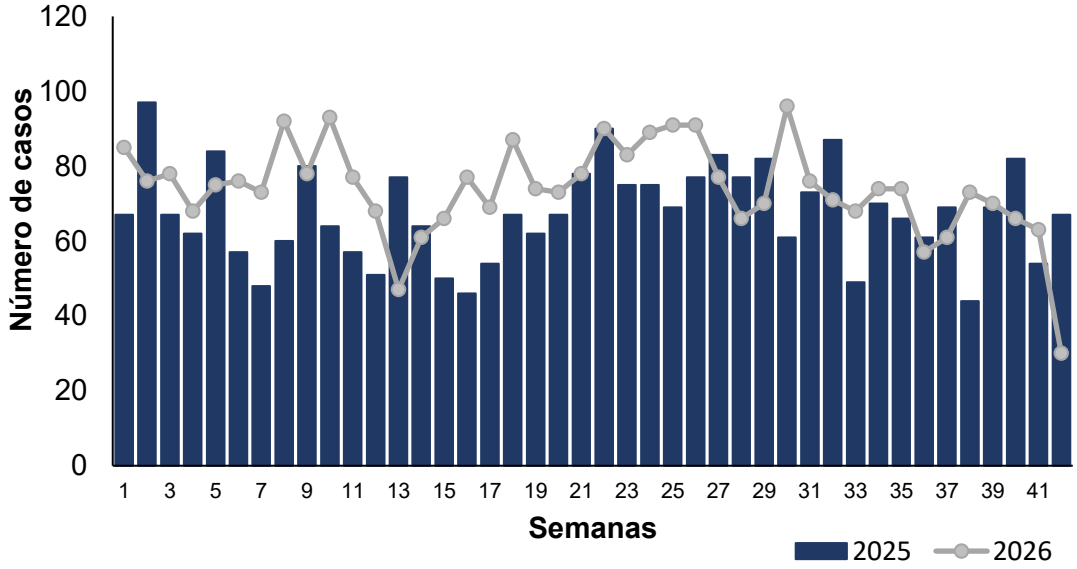
Infecciones de transmisión sexual

La notificación de las infecciones de transmisión sexual (ITS) es de carácter obligatorio, según lo establecido en el Decreto N.º 40556-S. En este marco, la vigilancia epidemiológica semanal de las ITS constituye una herramienta fundamental para el monitoreo de tendencias, la detección temprana de variaciones en la incidencia y la activación oportuna de medidas de control. En cumplimiento de este mandato, se presenta el informe correspondiente al comportamiento de las ITS a la semana cuarenta y dos del año 2026.

Sífilis en todas sus formas

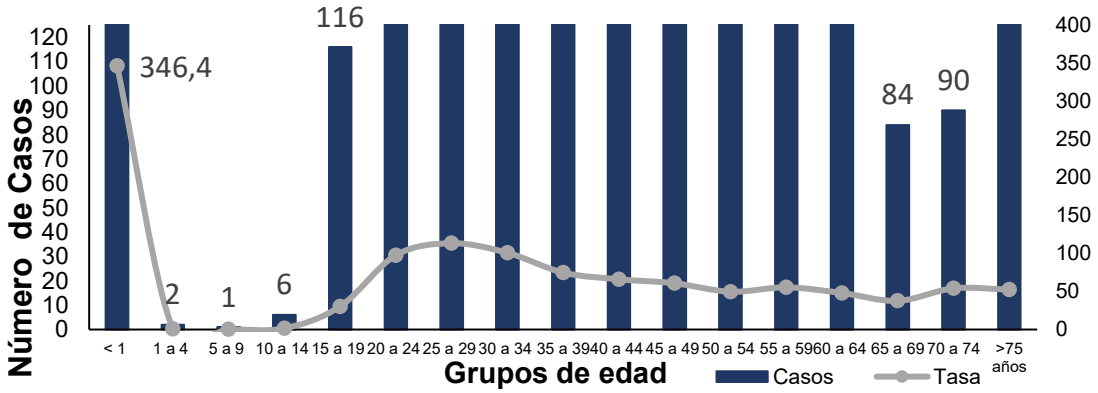
Hasta la semana epidemiológica 42 de 2026 se han notificado 3109 casos acumulados de sífilis, frente a 2603 en el mismo período de 2025. Esto significa 506 casos más y un aumento del 19,44 %. En promedio, la notificación pasó de unos 62 casos por semana en 2025 a unos 74 en 2026, alrededor de 12 casos semanales adicionales. El comportamiento es de incremento sostenido, coherente con la tendencia ascendente que OPS/OMS describe en las Américas, donde la sífilis sigue en aumento en adultos. En el Gráfico 1 se presenta la distribución semanal de los casos notificados, permitiendo visualizar el comportamiento del evento durante el período analizado.

Gráfico 1.
Costa Rica: Casos notificados por sífilis en todas sus formas, según fecha de inicio de síntomas en el reporte semanal, en los años 2025 y 2026



Nota: Datos preliminares sujetes a ser actualizados semanalmente.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2026.

Gráfico 2.
Costa Rica: Notificación de casos de sífilis en todas sus formas por grupos de edad, en semanas epidemiológicas 1 a 42 del 2026, según tasa por 100 000 habitantes.



Nota: Datos preliminares sujetos a ser actualizados.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2026.

Hasta la SE 42 de 2026 se notificaron 3109 casos de sífilis en todas sus formas, y la carga se concentra en adultos jóvenes. El grupo de 20 a 34 años reúne 1272 casos, el 40,9 % del total, y llega al 51,5 % si se extiende hasta los 39 años. La tasa más alta entre la población general corresponde a los 25 a 29 años, con 113,3 casos por 100 000 habitantes (467 casos), seguida de los 30 a 34 años (100,8) y los 20 a 24 años (97,7). Después de los 35 años la tasa baja de forma gradual, de 74,8 a 48,0 por 100 000 en el grupo de 60 a 64 años. Se observa un leve repunte en los 55 a 59 años (55,4) y en los 70 a 74 años (54,1), y en los mayores de 75 años se registraron 131 casos (52,5). En conjunto, los mayores de 50 años aportan 731 casos, el 23,5 % del total, lo que indica que la infección no se limita a edades jóvenes. En adolescentes de 15 a 19 años se notificaron 116 casos (30,3 por 100 000), más de tres veces menos que en el grupo de 25 a 29 años, pero con una carga que merece atención por el inicio temprano de la vida sexual.

Los 172 casos en menores de 1 año (tasa de 346,4 por 100 000) no deben interpretarse en bloque como sífilis congénita, porque cada uno requiere una valoración individualizada para establecer su clasificación. Hay que revisar el antecedente materno (tamizaje prenatal, momento del diagnóstico, esquema de penicilina benzatínica y su adecuación en dosis y tiempo, y tratamiento de la pareja), además del examen clínico del recién nacido, las pruebas serológicas comparadas con las de la madre y, cuando corresponda, estudios complementarios. Con esa información cada caso se clasifica como confirmado, probable, descartado o expuesto, según los criterios de definición de caso vigentes, y así se diferencia la sífilis congénita verdadera de la simple exposición con seguimiento.

Tabla 1.
Costa Rica: Notificación de casos de sífilis en todas sus formas, según provincias de procedencia, durante las semanas 1 a 40 del 2026. Tasa por 100 000 habitantes

Provincia	Casos	Tasa
Total	**2954**	**56,6**
San José	1200	72
Alajuela	362	33,4
Cartago	339	63,5
Heredia	250	45,4
Guanacaste	101	24,2
Puntarenas	200	39,3
Limón	502	109,6

Nota: Datos preliminares sujetos a revisión y actualización semanal.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2026.

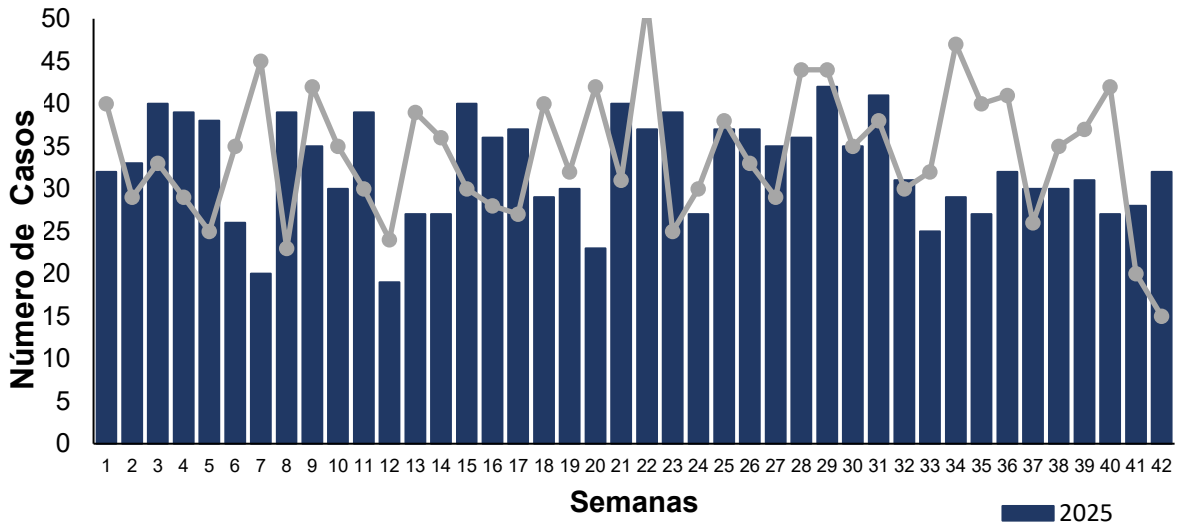
En relación con las provincias, San José reporta 1292 casos (41,6 % del total) y una tasa de 77,5, alrededor de 1,3 veces la nacional, lo que refleja su gran población y su alta densidad urbana. El hallazgo más llamativo es Limón: con 522 casos (16,8 % del total) tiene la tasa más alta del país, 114 por 100 000, casi el doble de la nacional y unas cuatro veces la de Guanacaste (26,9), pese a ser una provincia de baja densidad poblacional (según su tasa, representa cerca del 9 % de la población del país). Cartago (65,2) también supera el promedio nacional, mientras que Heredia (45,9), Puntarenas (41,9), Alajuela (34,1) y Guanacaste (26,9) quedan por debajo. Las cuatro provincias de la Gran Área Metropolitana concentran 2262 casos (72,8 %), por lo que la mayor parte de la carga absoluta está allí. En términos de riesgo, sin embargo, Limón y San José son las prioridades para reforzar el tamizaje, el tratamiento oportuno.

Infección por Gonorrea

Al cierre de la semana epidemiológica 42 de 2026, Costa Rica registra un acumulado de 1.428 casos notificados de gonorrea, en comparación con los 1.239 casos reportados durante el mismo período de 2025. Esto representa un incremento absoluto de 189 casos, equivalente a una variación porcentual del 15,25 %.

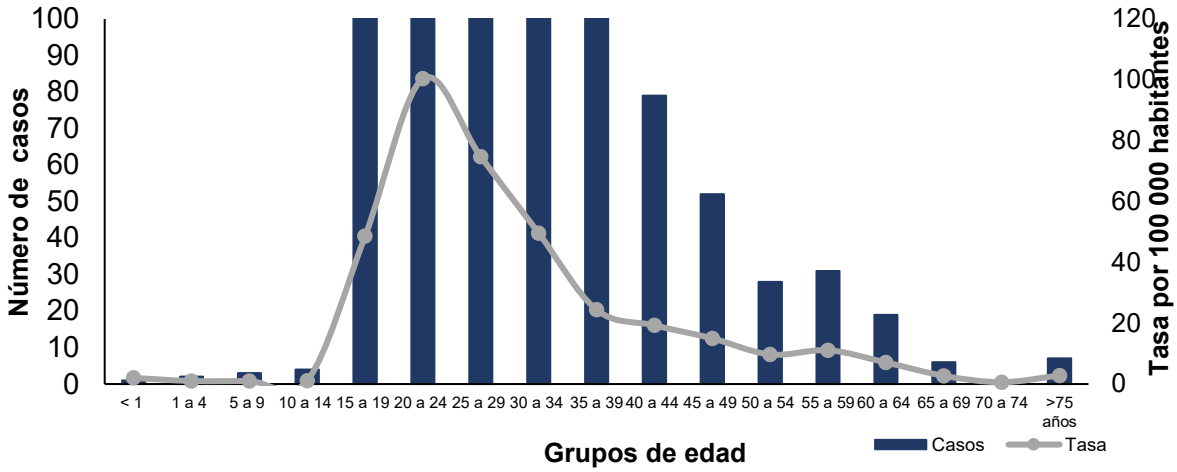
En el grafico 3 podemos observar el comportamiento según semana epidemiologica.

Gráfico 3
Costa Rica: Casos notificados por gonorrea, según reporte semanal por fecha de inicio de síntomas, en los años años 2025 y 2026



Nota: Datos preliminares sujeto a ser actualizado semanalmente.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 202

Gráfico 4
Costa Rica: Casos de gonorrea por grupos de edad número absoluto, y tasa por 100 000 habitantes, durante las 42 semanas del año 2026



Nota: Datos preliminares sujetos a ser actualizados semanalmente.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2026.

A la semana epidemiológica 42 de 2026, se registra un total de 1.428 casos notificados de gonorrea, con una tasa acumulada de 27,4 por 100.000 habitantes. La distribución por grupos de edad evidencia una mayor concentración de casos en la población adulta joven, particularmente entre los 20 y 24 años, que presenta el mayor número de casos (380) y la tasa más elevada (100,4 por 100.000 habitantes), seguido del grupo de 25 a 29 años, con 308 casos y una tasa de 74,7, y el de 30 a 34 años, con 214 casos y una tasa de 49,6. En conjunto, estos tres grupos concentran el 63,2 % de los casos notificados, lo que refleja una importante carga de la enfermedad en la población de 20 a 34 años.

Asimismo, destaca el grupo de adolescentes de 15 a 19 años, con 186 casos y una tasa de 48,6 por 100.000 habitantes. A partir de los 35 años se observa una disminución progresiva en la frecuencia de casos y las tasas de notificación, aunque la infección continúa presente en los grupos de mayor edad.

Tabla 2.
Costa Rica: Casos notificados por gonorrea, según provincia. Número absoluto y tasa por 100 000 habitantes, en las 42 semanas año 2026

Provincia	Casos	Tasa
Total	**1428**	**27,4**
San José	634	37,6
Alajuela	141	13
Cartago	144	27
Heredia	134	24,3
Guanacaste	38	9,1
Puntarenas	153	30,1
Limón	184	40,2

Nota: Datos preliminares sujetos a ser actualizado semanalmente.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2026.

A la semana epidemiológica 42 de 2026, la distribución geográfica de los casos notificados de gonorrea en Costa Rica evidencia diferencias importantes entre provincias. San José concentra el mayor número de casos, con 634 notificaciones y una tasa de 37,6 por 100.000 habitantes, seguida de Limón, con 184 casos y una tasa de 40,2, y Puntarenas, con 153 casos y una tasa de 30,1. Limón presenta la tasa de notificación más elevada del país, superando tanto la tasa nacional de 27,2 por 100.000 habitantes como la registrada en San José, lo que evidencia una mayor afectación relativa de su población. Cartago registra 144 casos y una tasa de 27,0, similar al promedio nacional, mientras que Heredia presenta 134 casos y una tasa de 24,3. Por su parte, Alajuela y Guanacaste muestran las tasas más bajas, con 13,0 y 9,1 por 100.000.

La distribución por sexo evidencia un marcado predominio de casos en hombres, quienes concentran el 87,5 % del total, mientras que las mujeres representan el 12,5 %, con una tasa de 6,8 por 100.000 mujeres. La tasa de notificación en hombres es aproximadamente 7 veces superior a la registrada en mujeres, lo que evidencia una importante diferencia en la distribución de la enfermedad según sexo. Este comportamiento podría estar relacionado con diferencias en los patrones de exposición, la búsqueda de atención médica y la detección de casos, considerando que la gonorrea puede cursar de manera asintomática, especialmente en mujeres, lo que favorece el subdiagnóstico.

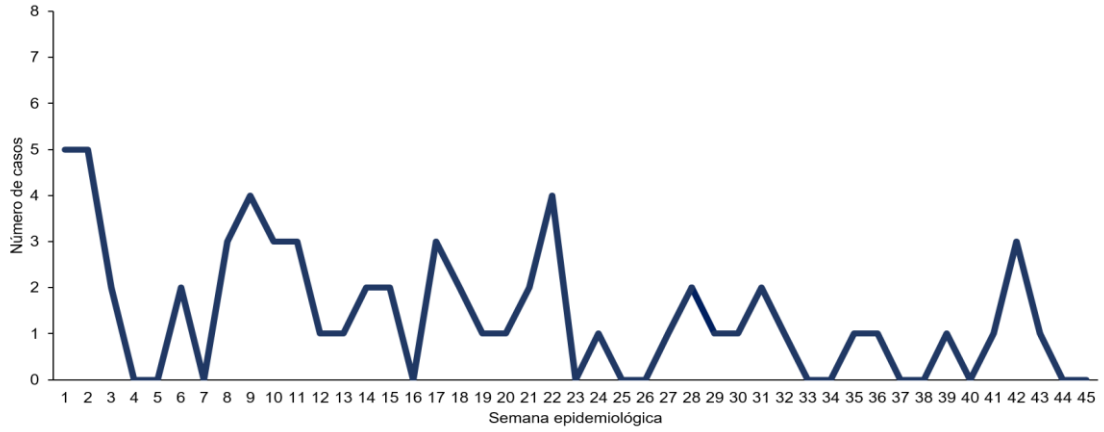
Miasis por gusano barrenador en humanos

A continuación, se presentan los datos preliminares de miasis por gusano barrenador en humanos correspondientes a la semana epidemiológica (SE) 43 del año 2026. De conformidad con lo establecido en el Decreto Ejecutivo N° 40556-S Reglamento de Vigilancia de la Salud y el Lineamiento Nacional para la Vigilancia de Miasis por Gusano Barrenador en Humanos, este evento es de notificación obligatoria al Ministerio de Salud.

Con respecto a la notificación de casos mediante la boleta VE-01, para el período comprendido entre la SE 1 a la SE 43 del año 2026, se dispone de la siguiente información:

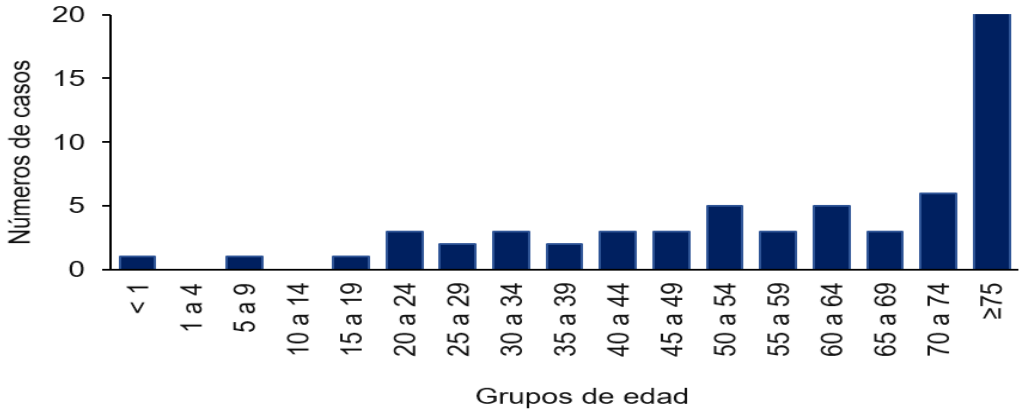
- Casos acumulados de miasis por gusano barrenado en humanos suman un total de 63 casos
- Casos por grupos de edad tienen un predominio en las personas de 20 a 64 años (29/63) y las adultas de 65 y más años con más casos reportados (31/63)

Gráfico 1
Costa Rica: Casos notificados de miasis de gusano barrenador según SE de la 01 a la 43, 2026



Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2026

Gráfico 2
Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador según grupos de edad quinquenal, de la SE 01 a la 43, 2026



Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2026

En 2026, hasta la SE 43, la distribución de los casos de miasis por gusano barrenador en humanos evidenció un predominio del sexo masculino, que concentró el 68,25% (43/63) de los casos notificados, con una tasa de incidencia de 1,7 casos por 100 000 habitantes. Por su parte, el sexo femenino representó el 31,75% (20/63) de los casos, con una tasa de incidencia de 0,8 casos por 100 000 habitantes.

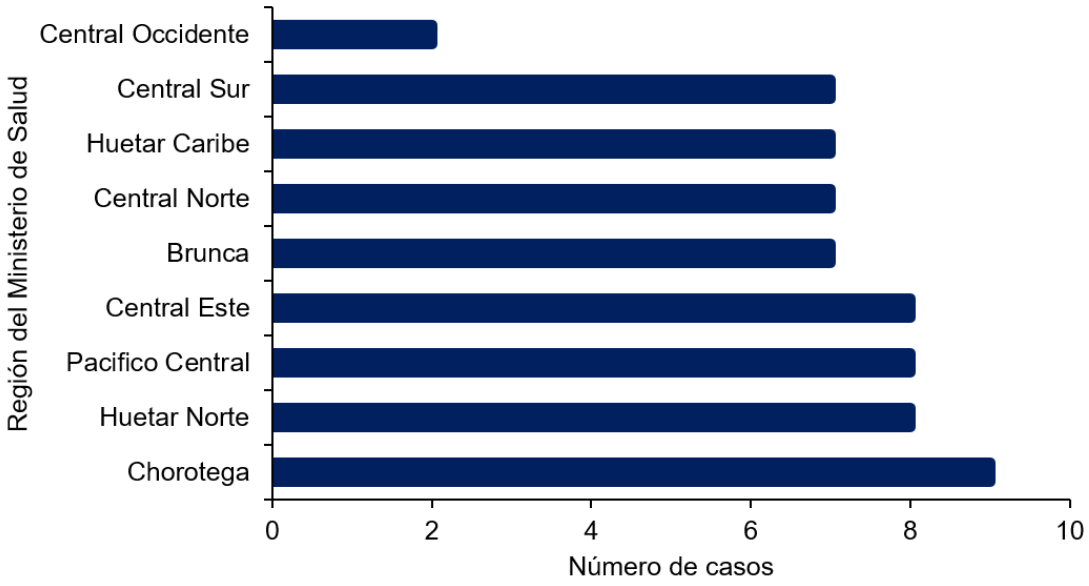
Tabla 1
Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador por número de casos y tasas (tasa p/100.000 habitantes) según provincia de procedencia, de la SE 01 a 43, 2026

Provincias	Casos	Tasas
Total	**63**	**1,2**
San José	11	0,7
Alajuela	13	1,2
Cartago	5	0,9
Heredia	5	0,9
Guanacaste	9	2,2
Puntarenas	13	2,6
Limón	7	1,5

Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2026

En la Tabla 1 se muestra la distribución de los casos de miasis por gusano barrenador en humanos notificados hasta la SE 43, según provincia de procedencia. Las provincias de Puntarenas (13/63) y Alajuela (13/63) concentran el mayor número de casos.

Gráfico 3
Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador por número de casos según región del Ministerio de Salud de procedencia, de la SE 01 a 43, 2026

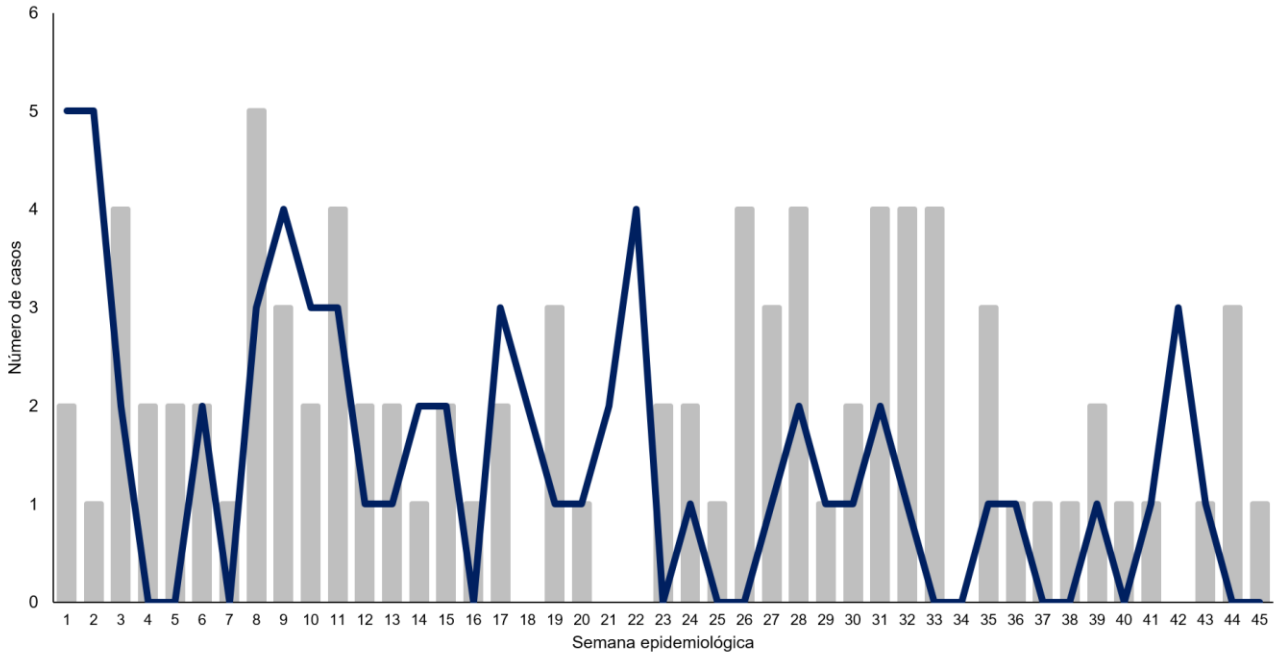


Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2026

En el Gráfico 3 se presenta la distribución de los casos de miasis por gusano barrenador en humanos notificados hasta la SE 43 en las nueve regiones rectoras del Ministerio de Salud. La Región Chorotega concentró el mayor número de casos, con 9 de los 63 casos registrados durante el período analizado.

Por su parte, el Gráfico 4 muestra el comportamiento de la miasis por gusano barrenador en humanos entre las SE 1 a la 43 de los años 2025 y 2026. Durante el año 2026 se notificaron 63 casos confirmados, mientras que para el mismo período de 2025 se habían confirmado 83 casos. Lo anterior representa una disminución de 21 casos (25%) en comparación con el año anterior.

Gráfico 4
Costa Rica: Casos notificados de miasis de gusano barrenador, según SE, de la SE 01 a la 43 del 2025 y del 2026



Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025 y 2026

En atención a la declaratoria de Emergencia Nacional Sanitaria Epidémica para el control y erradicación del Gusano Barrenador (*Cochliomyia hominivorax*), establecida mediante el Decreto Ejecutivo N° 44382–MAG, y considerando que la mosca continúa circulando en el territorio nacional, resulta de suma importancia que, ante la detección de un caso sospechoso en humanos, se active de manera inmediata la coordinación interinstitucional e intersectorial bajo el enfoque de **Una Sola Salud**.

Dicha coordinación involucra la participación del Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), según corresponda. El propósito es identificar oportunamente casos sospechosos en humanos y/o animales y garantizar su atención conforme a lo establecido en el **Lineamiento Nacional para la Vigilancia de Miasis por Gusano Barrenador en Humanos**.

A continuación, se presentan las disposiciones generales para la prevención y control de la enfermedad:

- Acudir oportunamente a los servicios de salud públicos o privados ante la presencia de síntomas compatibles con la enfermedad, tales como dolor, malestar y picazón en el sitio de la lesión, enrojecimiento de la piel, herida con secreción, sensación que se mueve y con frecuencia, se pueden observar huevecillos y/o larvas visibles en la lesión.
- Mantener una adecuada higiene personal, incluyendo el lavado frecuente de manos con agua y jabón.
- Realizar el control, tratamiento y cuidado higiénico de las lesiones conforme a las indicaciones del médico tratante.
- Mantener vigilancia y control en el cuidado de los animales, efectuando revisiones periódicas y la curación de todas las heridas. Asimismo, se deberá notificar a las autoridades de salud animal (MAG-SENASA y/o MINAE) la aparición de animales con gusaneras, a fin de garantizar su atención oportuna.

La Poliomielitis

El 24 de octubre 2025 se celebraron 53 años libres de casos de Poliomielitis en Costa Rica, el último caso se registró en agosto 1973. En setiembre de 1994, se certificó la eliminación de los países de Las Américas celebrando 31 años sin La Polio.

La Polio, es una enfermedad altamente contagiosa que afecta en gran medida a los niños menores de 5 años, causada por el virus polio, que invade el sistema nervioso y puede provocar parálisis permanente en piernas o brazos o muerte por afectación de los músculos respiratorios (2%-10% de los casos de parálisis). En la mayoría de los casos, el virus se transmite de persona a persona a partir de las heces de un individuo infectado. Respecto a la fuente de la infección, puede ser agua o alimentos contaminados con heces de la persona infectada, aunque también, puede generarse desde secreciones de las vías respiratorias (boca y nariz). (Organización Mundial de la Salud, 2026).

La Parálisis Flácida Aguda (PFA) es una condición médica caracterizada por músculos extremadamente débiles y el deterioro del tono muscular. La pérdida de la función muscular, sin el antecedente de trauma es una señal del daño al sistema nervioso, situación que requiere la atención inmediata de un médico. La Parálisis Flácida Aguda es el principal indicador para la sospecha de poliomielitis y se debe realizar un diagnóstico diferencial de otras enfermedades o causas como los traumas, entre otros.

La sintomatología que presenta esta enfermedad es muy similar a la de una gripe, como fiebre, dolores o debilidad musculares, dolor de cabeza y falta de apetito. Sin embargo, se debe sospechar en los niños no vacunados que después de 2 o 5 días, presentan dolores musculares intensos, movimientos musculares involuntarios y sensación de hormigueo en piernas o brazos. Posteriormente, se presenta disminución de la fuerza muscular y dificultad para caminar, progresando rápidamente hasta ocasionar la parálisis, la cual suele ser desigual entre los miembros afectados.

La población con mayor riesgo, son las personas menores de 15 años no vacunadas, y los menores de cinco años son las más susceptibles. El riesgo, se genera cuando se encuentran otras personas no vacunadas en un mismo espacio y en ambientes con malas condiciones de higiene.

El esquema de vacunación es a los 2, 4 y 6 meses, con dosis refuerzo una a los 15 meses y otra a los 4 años. En Costa Rica la cobertura de vacunación es superior al 95% logro que ha permitido proteger a la población costarricense.

Antecedentes y Epidemiología

En Costa Rica, esta enfermedad se desarrolló en pequeños brotes hasta el año 1936, año en que se registró la primera epidemia, con 17 casos. En el periodo de 1936 y 1973 se presentaron 11 epidemias, donde la más severa se presentó en 1954 con 1081 casos. En 1956 se iniciaron una serie de campañas de vacunación y programas permanentes de inmunización, que lograron altas coberturas y permitieron la erradicación de la enfermedad en el territorio nacional. El último caso confirmado en el país se registró en 1973. La eliminación de la poliomielitis en Costa Rica se logró gracias a la vacunación y a un sistema de vigilancia efectivo, sin embargo, siempre existe riesgo de enfermarse, debido al ingreso de una persona con la enfermedad (casos importados) o personas sin vacuna que visitan países con casos confirmados, como Afganistán, Pakistán, Malawi, Mozambique, entre otros, razón por la cual se debe estar vacunado contra la polio.

Este evento se vigila desde antes de los años 70, es de notificación obligatoria desde abril de 1983 según el Decreto Ejecutivo N° 14496-SPPS, pertenece al Grupo A, la notificación debe hacerse semanalmente para determinar su distribución y comportamiento. La vigilancia epidemiológica de la polio es a través de los casos sospechosos que presentan para la parálisis flácida aguda (PFA), especialmente en menores de 15 años, generalmente, la enfermedad ocasiona dificultad para caminar, o afecta la movilidad en las extremidades.

En el país, todos los años se registran casos sospechosos de poliomielitis, se realiza una investigación clínica epidemiológica, y se descartan por exámenes de laboratorio realizados en el Centro Nacional de Virología del Inciensa. La vigilancia de los casos sospechosos es estricta, todo caso de con parálisis flácida se notifica

al sistema de salud y por exámenes de laboratorio se descartan los casos. En el año 2025 se reportaron 33 casos sospechosos con parálisis flácida descartados por el laboratorio (tasa de 3,38 casos sospechosos por cada 100 000 niños menores de 15 años). Durante el año 2026, se han reportado 17 casos sospechosos, todos descartados con resultados negativos en el laboratorio.

El Comité Mundial Regional de Recertificación en el 2026, renovó el estatus de Certificación de la Eliminación de Polio para Costa Rica, resultado posterior a informes, evidencias y evaluaciones elaborados por el Equipo Técnico Nacional (Unidad de Epidemiología de la Dirección de Vigilancia del Ministerio de Salud, Subárea de Epidemiología de la CCSS, Centro Nacional de Referencia Virológica del Inciensa).

El país ha cumplido con lo solicitado por la Comisión Mundial de la Certificación de la Eliminación entre las actividades requeridas, se eliminaron las muestras biológicas y todo material infecto contagioso de los laboratorios y establecimientos. Además, el país reporta en los últimos años coberturas de vacunación iguales o mayores al 95 %, condición que se debe mantener en el tiempo, al igual que una vigilancia epidemiológica efectiva para estar protegidos contra el virus de la poliomielitis.

El trabajo del Equipo Nacional ha logrado contar con un lineamiento actualizado, denominado Protocolo para la Vigilancia Epidemiológica de La Poliomielitis, se elaboró y se concluyó en octubre del 2025, publicado en la página del Ministerio de Salud.https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos-left/documentos-ministerio-de-salud/vigilancia-de-la-salud/normas-protocolos-guias-y-lineamientos/protocolos-vigilancia-de-la-salud/9947-protocolo-para-la-vigilancia-epidemiologica-de-la-poliomielitis/file

Recomendaciones a la población en general

La medida más efectiva para prevenir la poliomielitis es la vacunación. Es fundamental que los padres y cuidadores revisen periódicamente el carné de vacunación de los menores y acudan a los centros de salud para completar las dosis necesarias.

La higiene personal juega un papel esencial en la prevención de esta enfermedad. Es importante lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia, especialmente después de ir al baño o cambiar pañales y antes de preparar alimentos.